BOLETIM DE RESULTADOS

Estudo III



Saúde do trabalhador

e a covid-19

GPST Grupo de Pesquisa Subjetividade e Trabalho
CNPq
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Thaís Augusta de Oliveira Máximo
Tatiana de Lucena Torres
Adson Cunha
Marcus Carvalho
(Coordenadores)

BOLETIM DE RESULTADOS

Estudo II



Saúde do trabalhador e a covid-19

Boletim de resultados do Estudo II é uma publicação do projeto Saúde do trabalhador e a covid-19

Núcleo de Comunicação
Coordenação e edição de texto: Suéllen Rodrigues
Projeto gráfico e arte: Gabrielly Nascimento

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENADORA
Thaís Augusta de Oliveira Máximo

VICE-COORDENADORA
Tatiana de Lucena Torres

NÚCLEO DE PSICOLOGIA
Amanda Wanderley Leite de Sousa
Ana Luisa Adissi Machado
Daniely Jéssica Tenório Santana
Elza Maíza de Assis Vaz
Erick Idalino Moura
José Ulisses do Nascimento
Lígia Lima Ferraz
Linniker Matheus Soares de Moura
Lucas Eurikes Melo Vasconcelos
Maria Beatriz Franco de Medeiros
Maria Eduarda Dias Gomes
Maria Luiza Benício Lopes
Rian Enedino Pereira Cruz
Valéria Nicolau de Sousa
Wesley Jordan Pereira da Silva

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
José Adson Oliveira Guedes da Cunha
Marcus Williams Aquino de Carvalho

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Arthur Silva Cavalcante Ferreira
Beatriz Maciel de Souza
Gabriel Ribeiro Dias
Jhonatas Flor de Sousa
Relbert Ruan Marculino de Medeiros
Walterlly Nicolau de Sousa

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Suéllen Rodrigues Ramos da Silva

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Maurício de Melo Apolinário Júnior
Rayssa Beatriz Oliveira



APRESENTAÇÃO

Este boletim apresenta resultados da coleta de dados do terceiro estudo do projeto “A saúde dos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia da covid-19: prevenção e cuidado” (Universidade Federal da Paraíba/CNPq). Temos o intuito de analisar as percepções acerca das condições de saúde e segurança no trabalho para trabalhadores/as da saúde que atuam no enfrentamento à pandemia da covid-19 no Nordeste, bem como caracterizar o perfil socioeconômico, laboral e de comportamento.

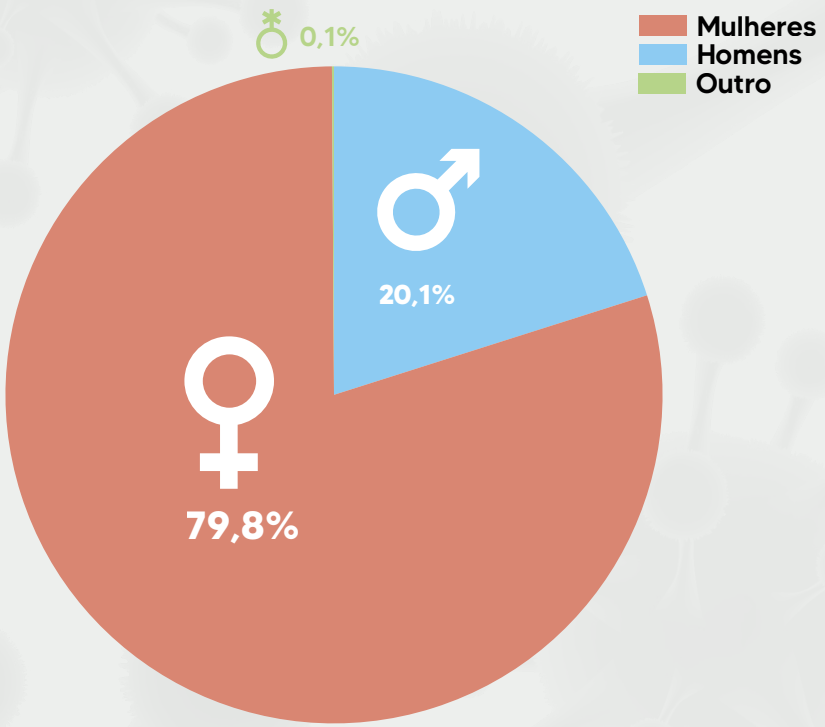
Nesse estudo, do qual participaram 1.003 trabalhadores/as da saúde, a coleta se deu de forma híbrida, por meio de aplicações presenciais e remotas, entre os meses de agosto de 2021 e abril de 2022, e teve como público-alvo profissionais da saúde da rede pública e privada atuantes diante da covid-19 em todos os estados nordestinos.



DESCRITIVOS

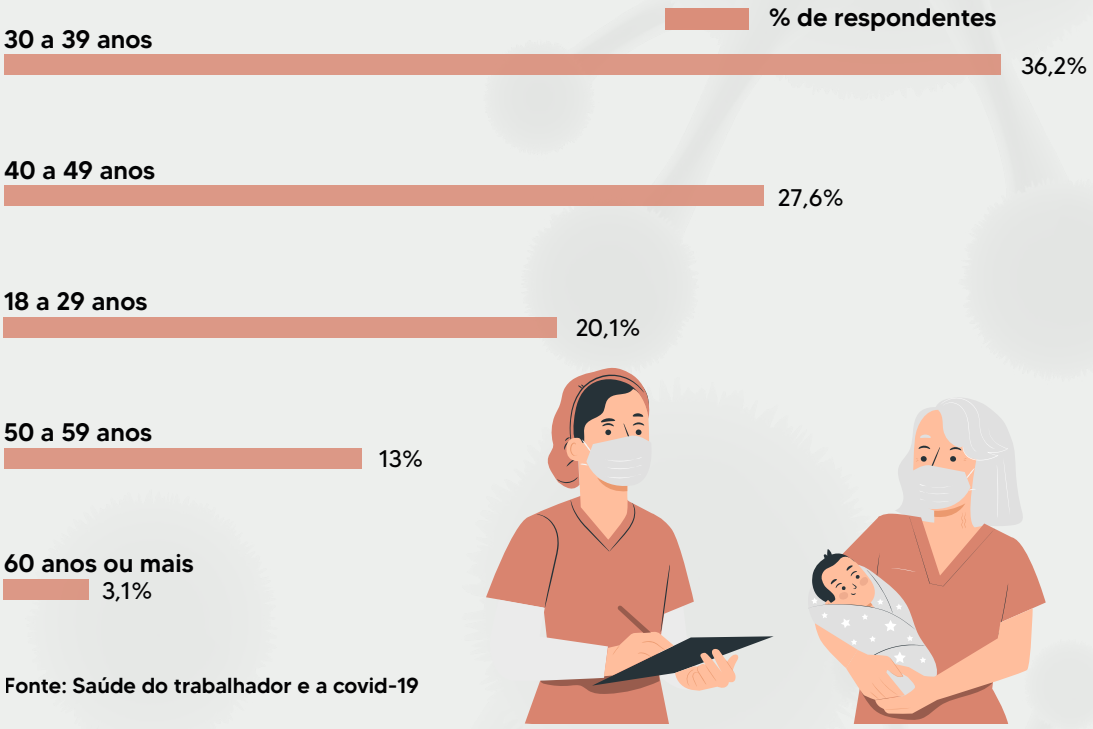
A amostra foi formada majoritariamente por pessoas do sexo feminino (79,8%) e, exibindo uma forte tipificação de gênero quanto à idade, a maioria dos/das profissionais se encontra na faixa dos 30 aos 49 anos (63,8%). Quando questionados/as sobre sua cor de pele, a maioria dos/das participantes afirmou se identificar com as cores parda (51,8%) e branca (31,2%).

Gráfico 1. Gênero



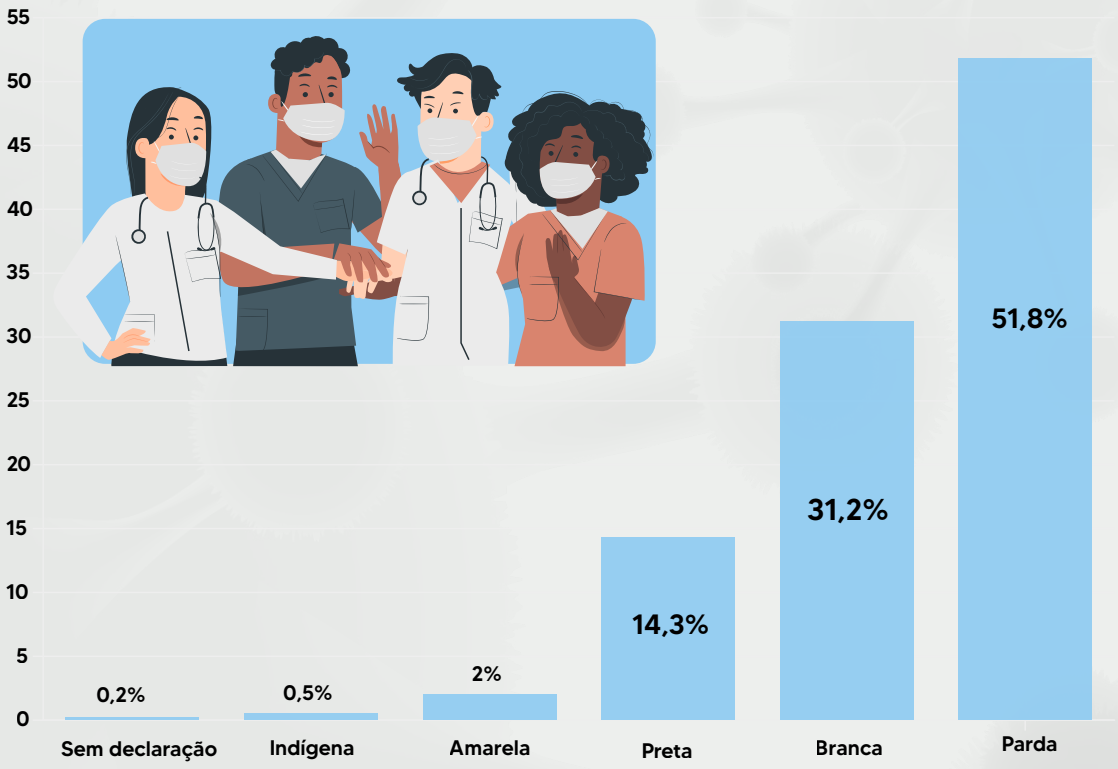
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 2. Idade



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

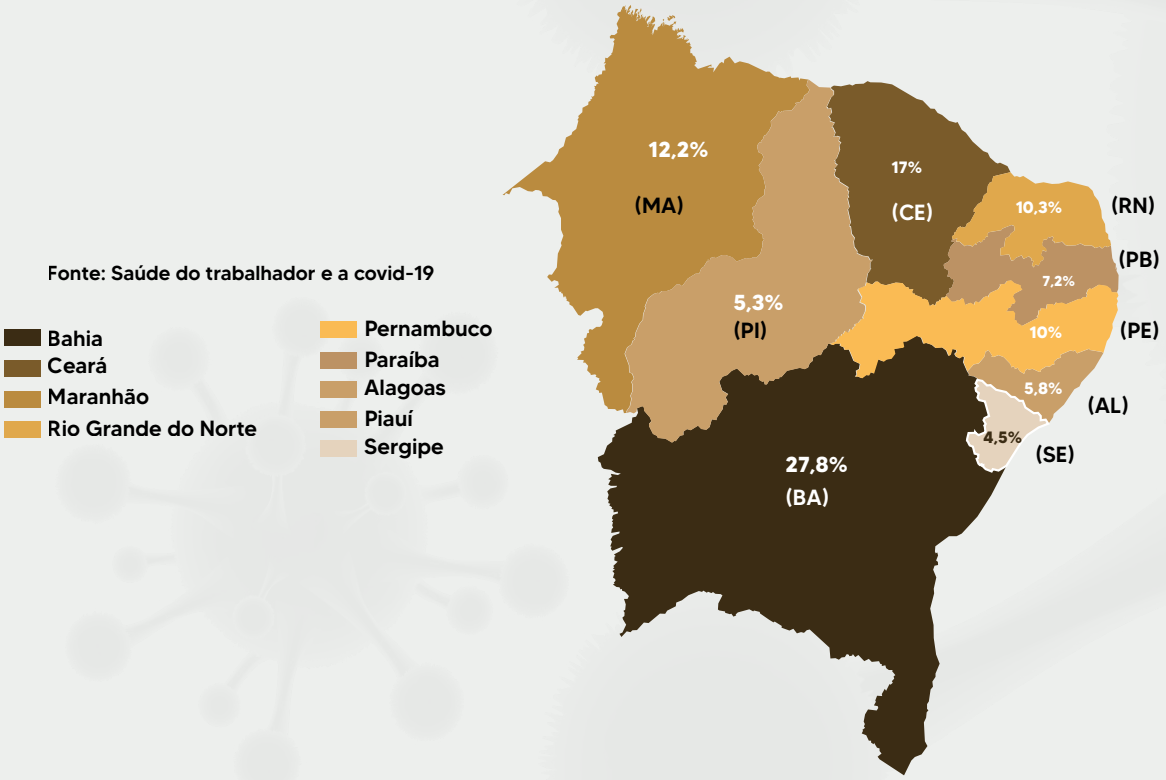
Gráfico 3. Raça



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Ao analisar a distribuição de participantes quanto ao estado de atuação, vemos que, dentre todos os nove estados da região Nordeste, a Bahia foi a mais representativa (27,8%), com Ceará (17%) e Maranhão (12,2%) logo em seguida.

Gráfico 4. Principal estado onde atua



Foi observado um alto grau de escolarização, uma vez que a maior parte dos/das profissionais realizaram uma pós-graduação (52,3%). Dentre as 19 diferentes ocupações observadas, as mais presentes foram a de enfermeiro/a (25,3%) e técnico/a ou auxiliar de enfermagem (15,2%), e, a respeito do tempo que o/a profissional desempenha essa função, 40% afirmaram desempenhar há mais de dez anos.



Gráfico 5. Escolardade

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

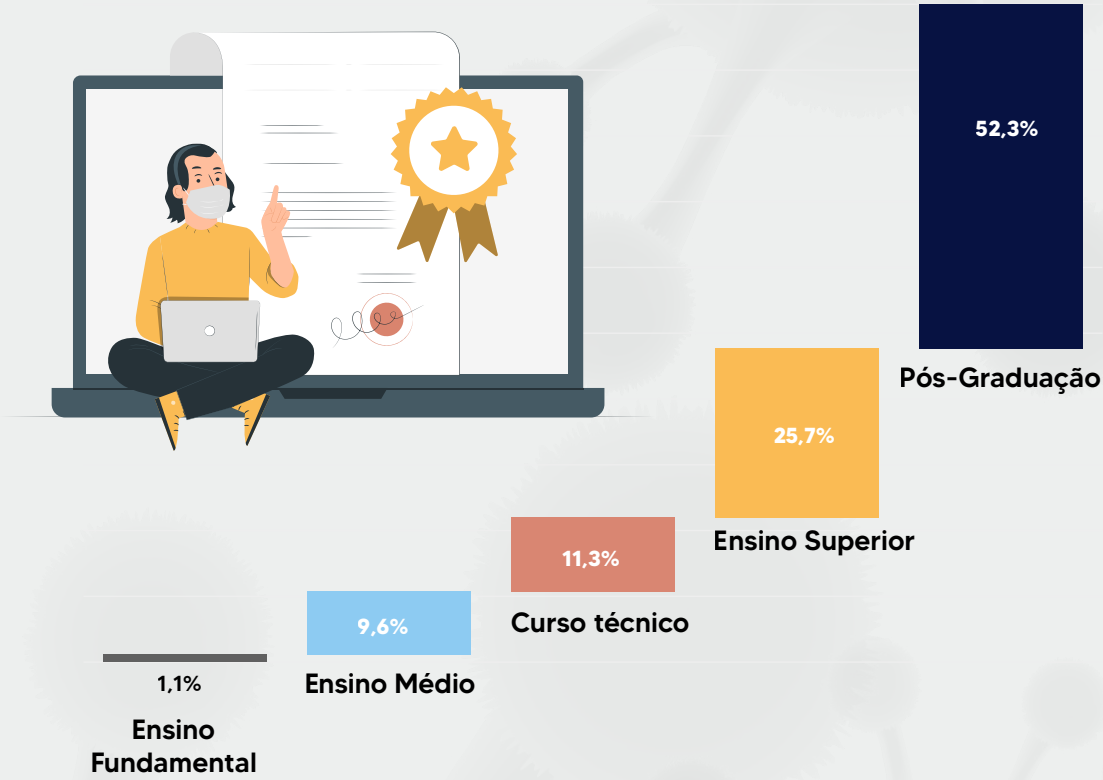
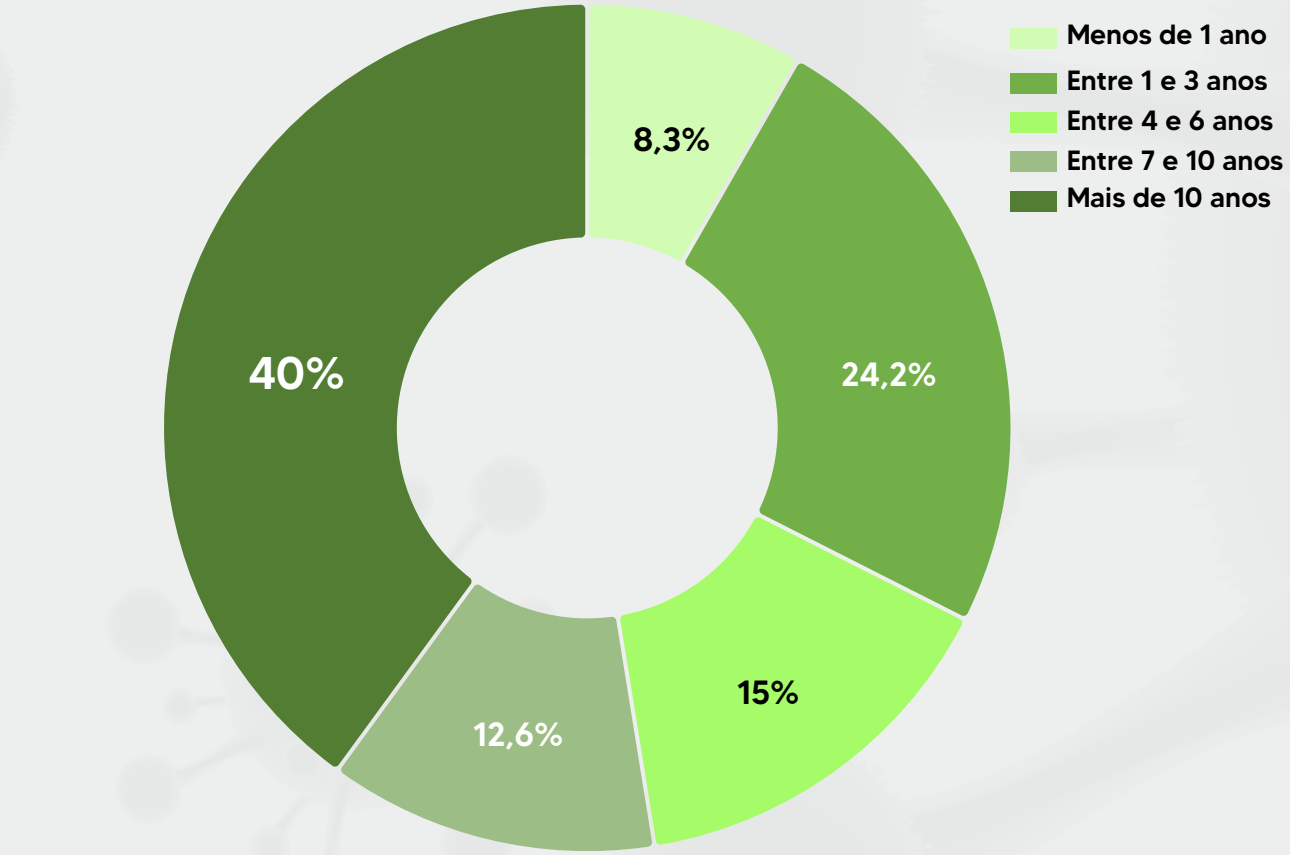


Gráfico 6. Função Principal



Gráfico 7. Tempo que exerce sua principal função

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

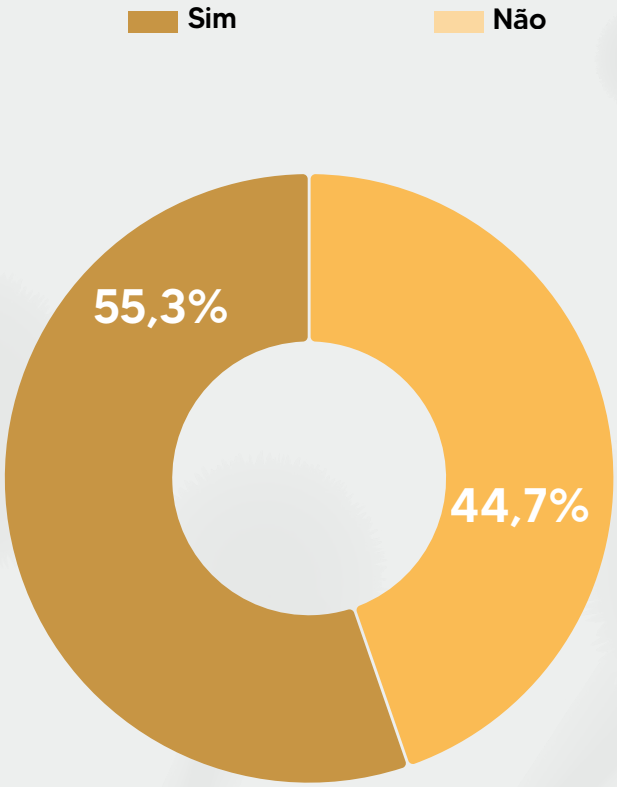


A maioria dos/das participantes (55,3%) já havia obtido diagnóstico positivo para a covid-19, e 99,1% já havia completado o esquema vacinal disponível até o momento da coleta dos dados para prevenir a infecção.

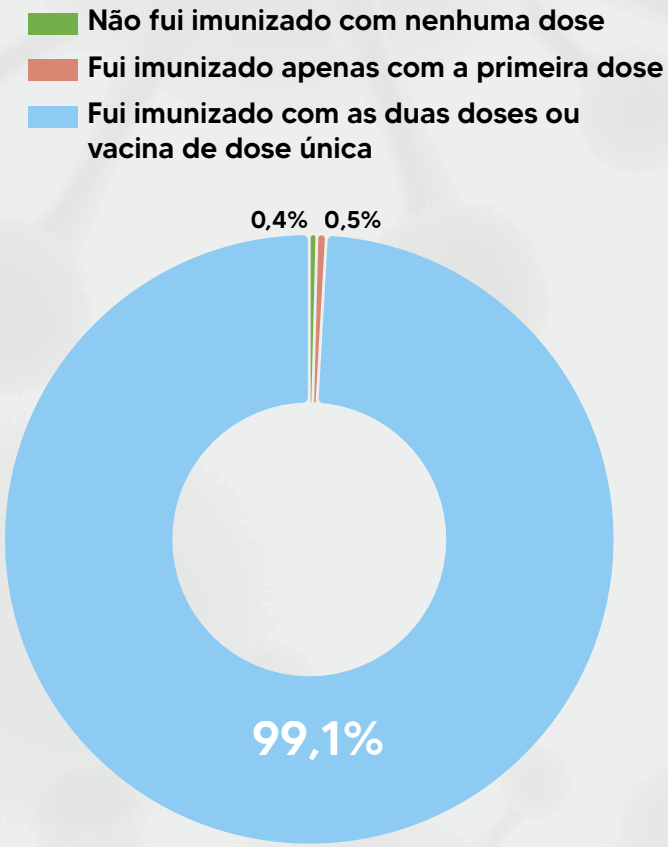


Gráficos 8 e 9. Você foi diagnosticado com covid? / Você se vacinou?

Você foi diagnosticado com covid-19?



Você se vacinou?





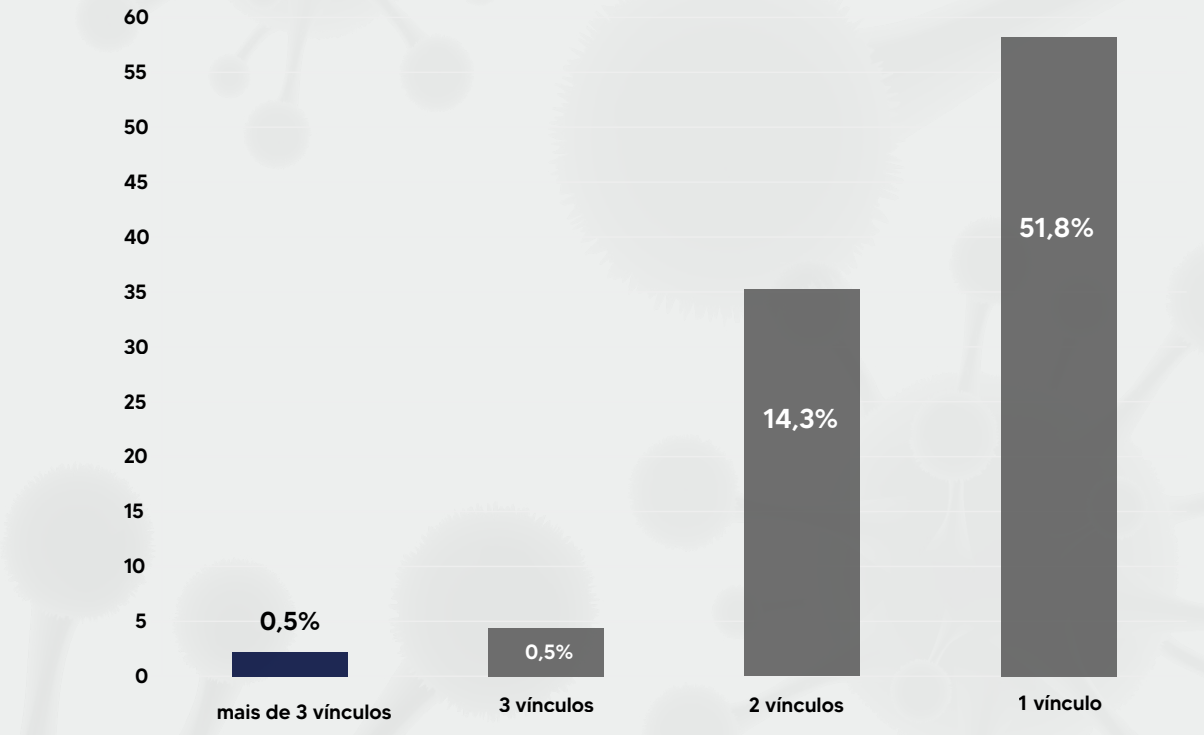
Regime e relações de trabalho

Vínculos de trabalho

No gráfico 10, conseguimos observar a quantidade de vínculos de trabalho dos/das profissionais de saúde participantes da pesquisa. Grande parte dos/das trabalhadores/as possuem entre um e dois vínculos de trabalho. Nota-se que mais da metade dos/das profissionais possui um vínculo de trabalho (58,2%), além dos/das demais trabalhadores/as indicarem que têm dois vínculos (35,2%). Em menor parcela da amostra, estão aqueles/as que possuem três vínculos (4,4%) ou mais de três vínculos de trabalho (2,2%).

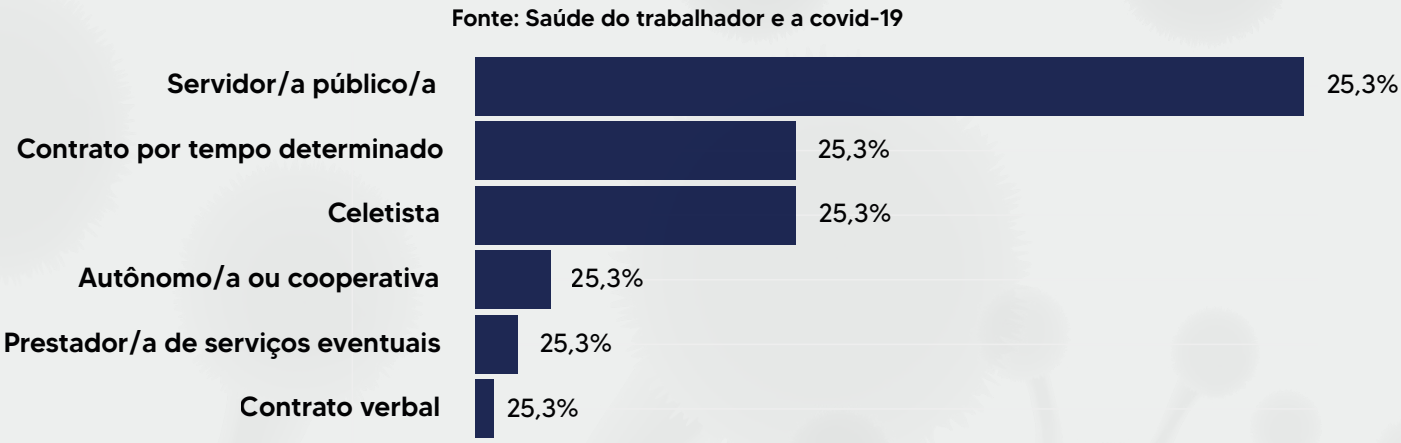
Gráfico 10. Quantidade de vínculos de trabalho

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Sobre o tipo de vínculo de trabalho na principal atividade profissional, é possível perceber, no gráfico 11, que os/as trabalhadores/as da amostra são em maior número servidores/as públicos/as (54,1%). Também notamos profissionais com vínculo de contrato por tempo determinado (20,9%) — vínculo frequente devido à necessidade de contratação de novos/as profissionais, além de trabalhadores/as com vínculo celetista (16,1%), autônomos/as ou de cooperativa (4,9%), prestadores/as de serviços eventuais (2,8%) e com vínculo de contrato verbal (1,2%).

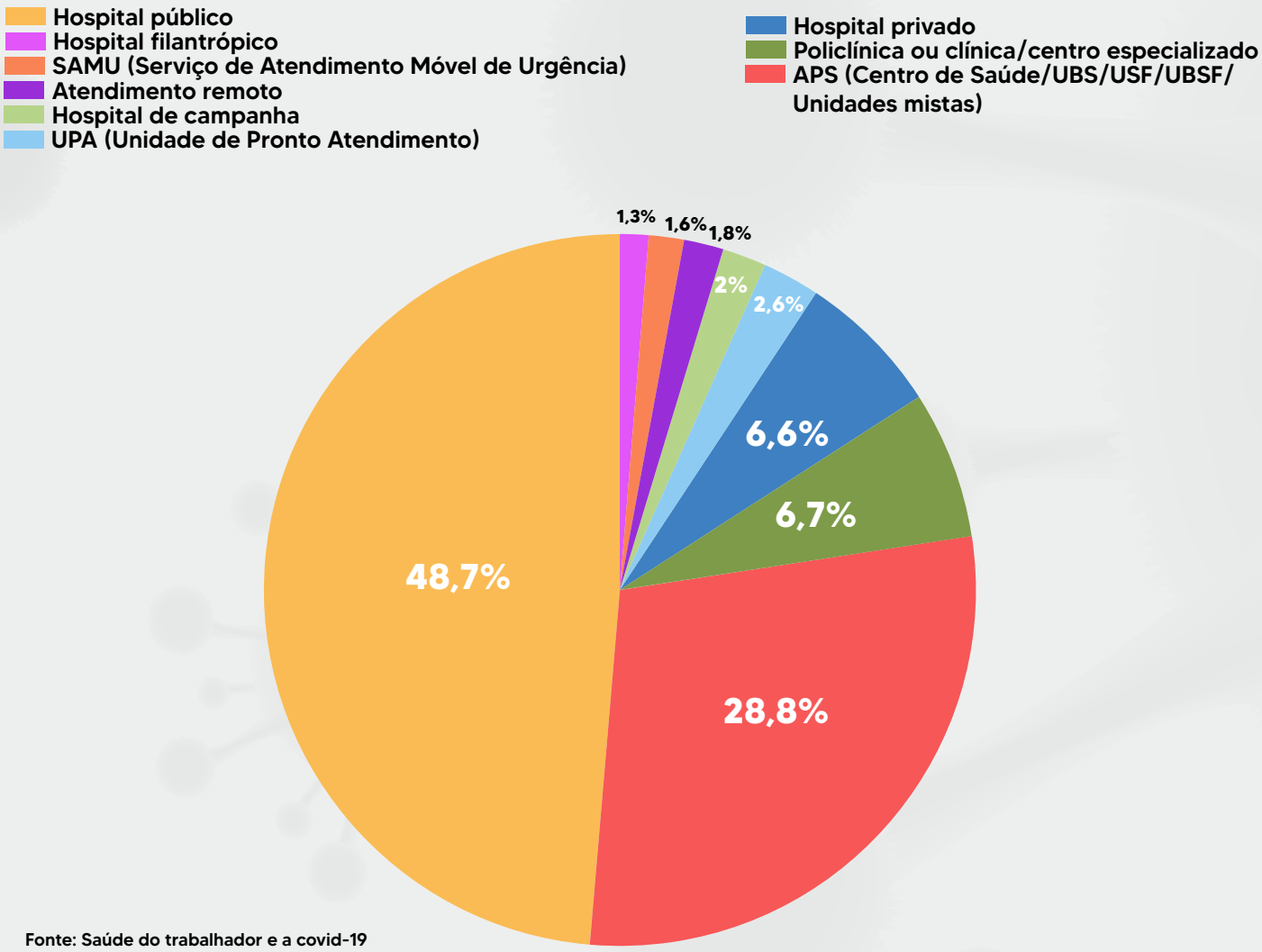
Gráfico 11. Tipo de vínculo da atividade principal



Tipos de instituições de atuação e nível de atenção

Quanto ao tipo de instituição onde esses/as profissionais trabalham, destacam-se os hospitais públicos (48,7%) e instituições de Atenção Primária em Saúde – APS (28,8%), tais como centros de saúde, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Unidades de Saúde da Família – USF, Unidades Básicas de Saúde da Família – UBSF ou unidades mistas. Além disso, é possível observar a contribuição de profissionais de instituições diversas como policlínicas ou clínicas / centros especializados (6,7%), hospitais privados (6,6%), Unidades de Pronto Atendimento – UPA (2,6%), hospitais de campanha (2,0%), atendimentos remotos (1,8%), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu (1,6%) e hospitais filantrópicos (1,3%).

Gráfico 12. Tipo de instituição em que trabalha no principal vínculo



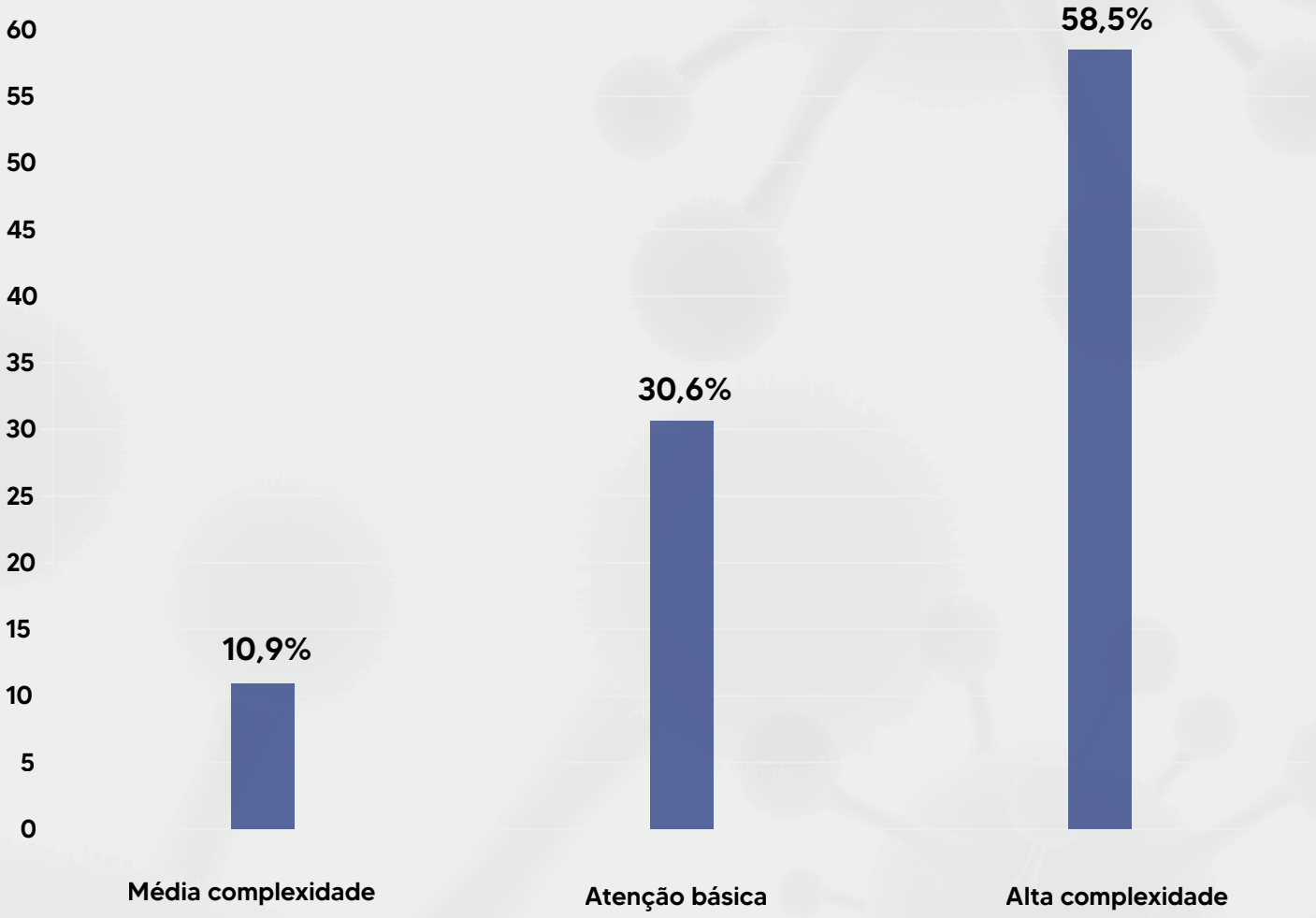
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Em relação ao nível de atenção da rede de saúde em que esses/as trabalhadores/as desempenham suas atividades profissionais, tem-se que a maioria pertence à alta complexidade (58,5%), com presença também de trabalhadores/as da atenção básica (30,6%) e da média complexidade (10,9%).



Gráfico 13. Nível de atenção

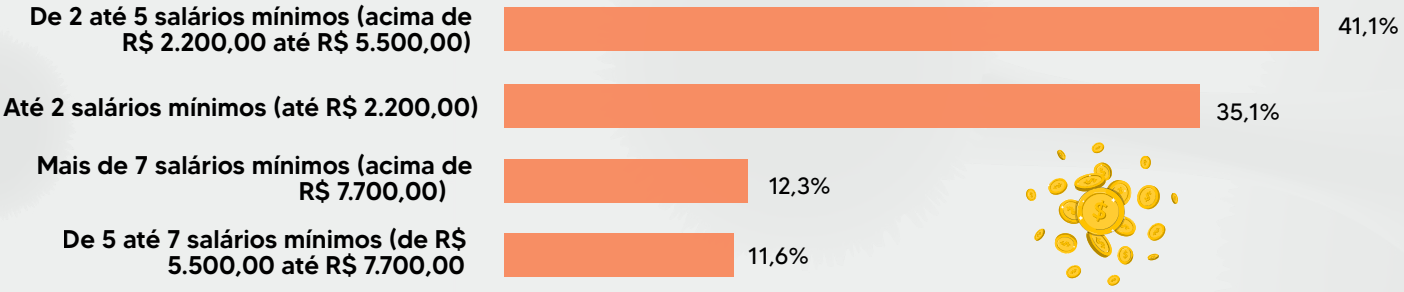
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Remuneração mensal

Quanto à remuneração mensal líquida dos/das trabalhadores/as, é possível observar no gráfico 14 que 41,1 % dos/das profissionais recebem de dois até cinco salários-mínimos (acima de R$ 2.200,00 até R$ 5.500,00) e 35,1% recebem até dois salários-mínimos (até R$ 2.200,00). Em menor número, estão trabalhadores/as remunerados/as com mais de sete salários-mínimos, acima de R$ 7.700,00 (12,3%) e aqueles/as que têm remuneração de cinco até sete salários-mínimos, de R$ 5.500,00 até R$ 7.700,00 (11,6%).

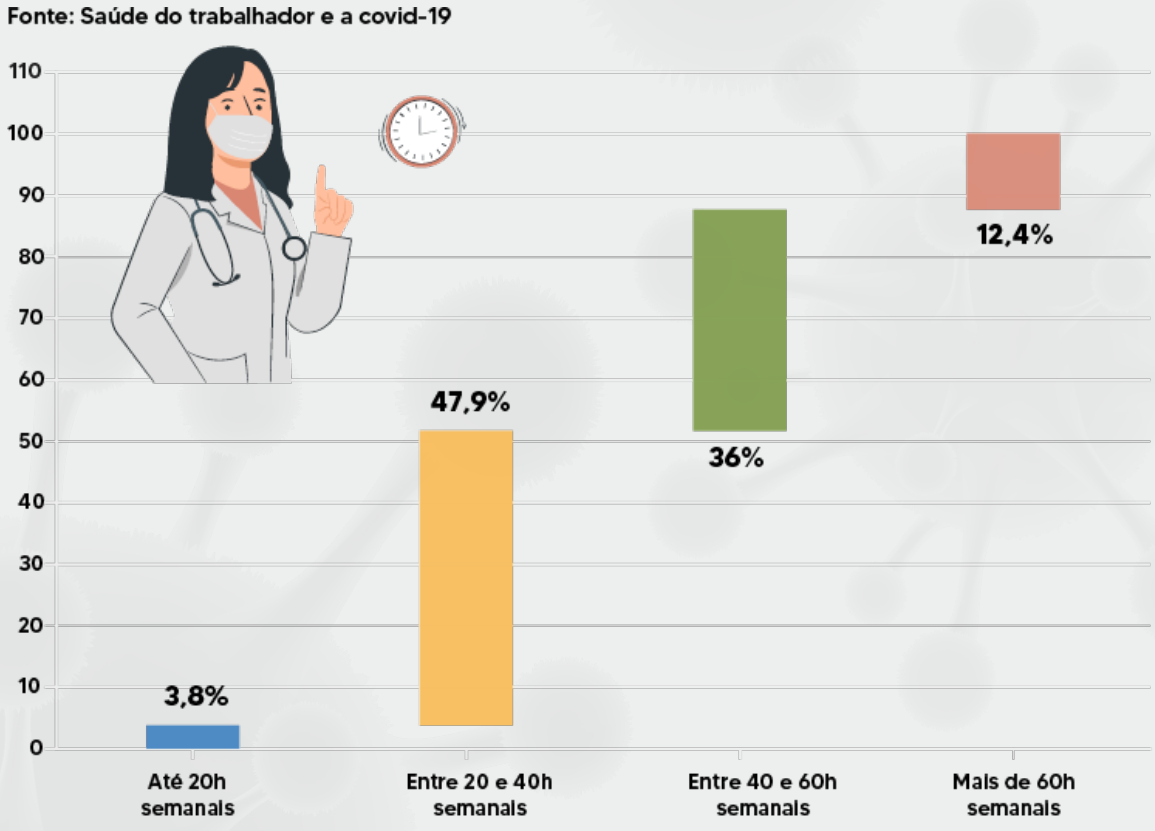
Gráfico 14. Remuneração mensal líquida



Jornada de trabalho

Sobre a jornada de trabalho, o gráfico 15 mostra que 47,9% dos/das profissionais têm jornadas entre 20 e 40 horas semanais e 36 % expediente de trabalho entre 40 e 60 horas semanais. Além disso, também se notam profissionais com jornadas de trabalho com mais de 60 horas semanais (12,4%) e, em menor quantidade, estão trabalhadores/as que possuem até 20 horas semanais de carga horária de trabalho (3,8%).

Gráfico 15. Jornada de trabalho



Formação e condições de trabalho

Treinamento para atuar no combate à covid-19

Em relação ao recebimento de treinamentos específicos, 52,1% relataram que receberam treinamento específico para a atuação no combate à covid-19 e 47,9% afirmam que não receberam tal treinamento.

Sobre os tais treinamentos, 34,2% relataram que esses treinamentos não serviram para nada, 21,2% afirmaram que os treinamentos contribuíram um pouco e 27,7% que os treinamentos contribuíram muito para a sua atuação. Por sua vez, cerca de 16,8% dos/das trabalhadores/as afirmam que o treinamento recebido foi uma contribuição totalmente suficiente para a atuação na pandemia.

Gráfico 16. Recebeu treinamento específico para atuar no combate à covid-19?

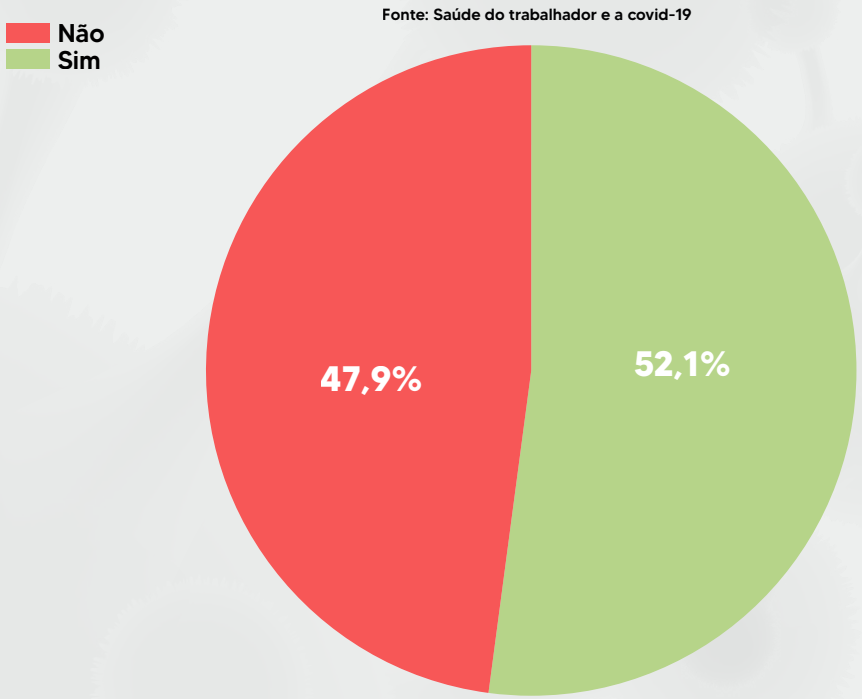
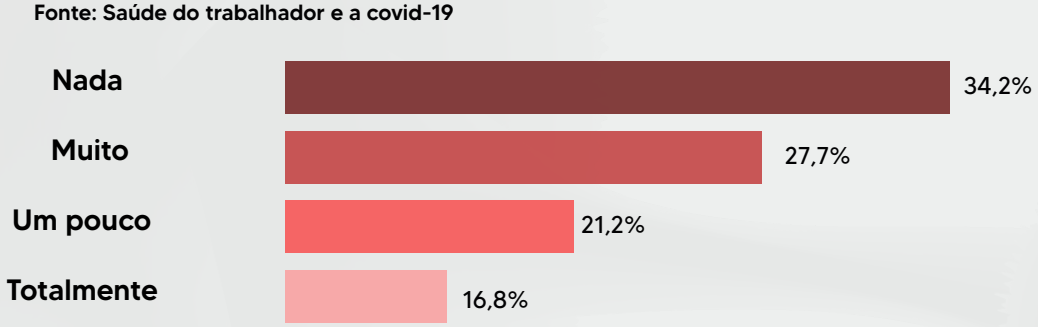


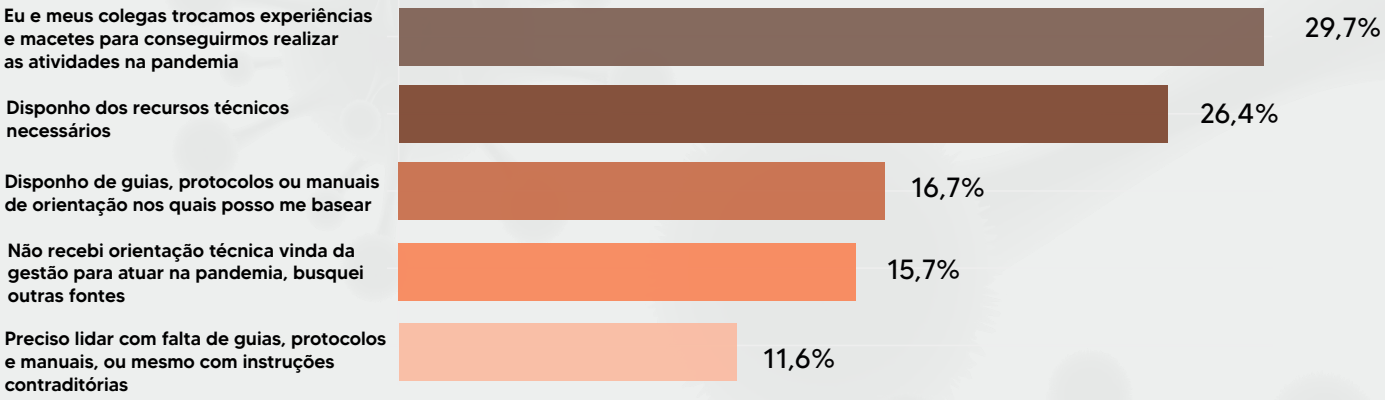
Gráfico 17. Esse/s treinamento/s contribuíram para a sua atuação frente à covid-19



Orientações e condições de trabalho que caracterizam a atividade que desenvolvem

No que diz respeito às orientações e condições de trabalho, 11,6% mencionaram que precisam lidar com falta de guias, protocolos e manuais, ou mesmo com instruções contraditórias; 16,7% afirmaram dispor de guias, protocolos ou manuais de orientação nos quais podem se basear; 26,4% relataram que dispõem dos recursos técnicos necessários; 29,7% que eles/as e seus colegas trocam experiências e macetes para conseguirem realizar as atividades na pandemia; e 15,7% alegaram não receber orientação técnica vinda da gestão para atuar na pandemia, precisando, assim, buscar outras fontes.

Gráfico 18. Caracterização das orientações e condições de trabalho

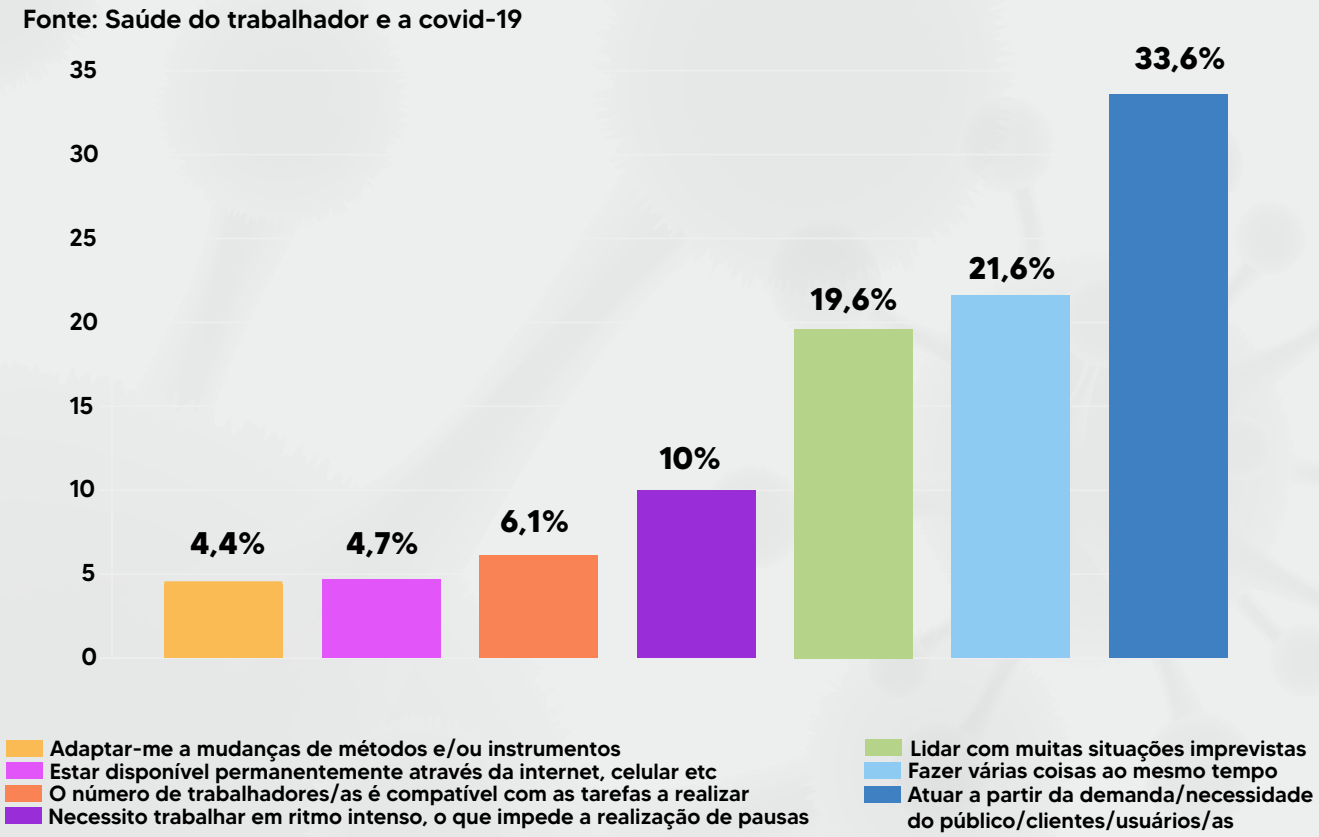




Cotidiano de trabalho

No que se refere ao aspecto que melhor caracteriza o cotidiano de trabalho, o gráfico 19 representa que a atuação a partir da demanda ou necessidade do público / clientes / usuários/as (33,6%); a execução de várias coisas ao mesmo tempo (21,6%) e lidar com muitas situações imprevistas (19,6) são os aspectos que melhor caracterizam o dia a dia de trabalho dos/das profissionais de saúde. Além disso, é possível observar como características desse cotidiano de trabalho: a necessidade de trabalhar em ritmo intenso, impedindo a realização de pausas (10 %); o número de trabalhadores/as compatível com as tarefas a serem realizadas (6,1%); assim como o/a trabalhador/a estar disponível permanentemente através da internet, celular etc. (4,7%); e ter que se adaptar à mudança de métodos e/ou instrumentos (4,4%).

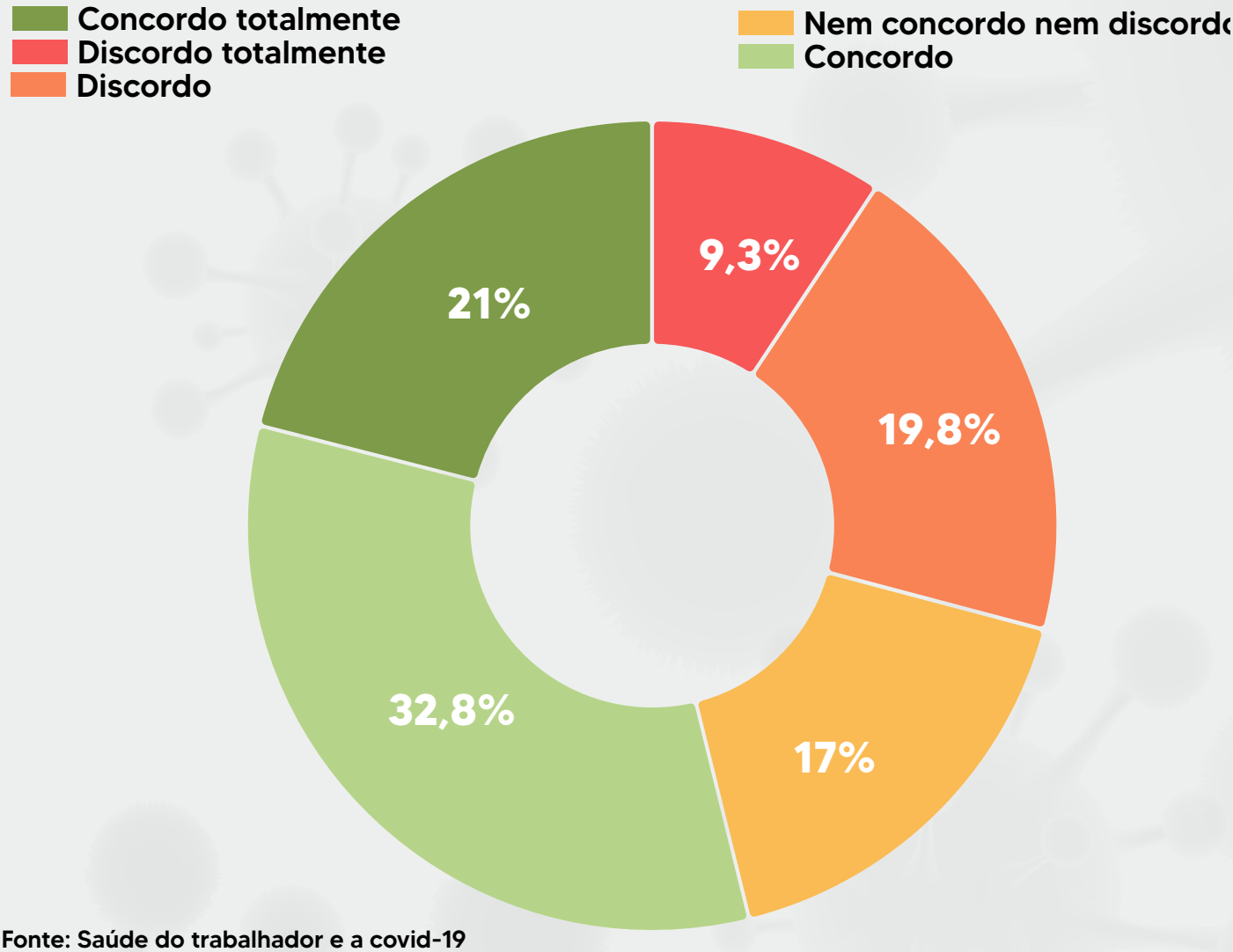
Gráfico 19. Caracterização do dia a dia de trabalho



Riscos e segurança no trabalho

"Meu trabalho é arriscado e perigoso", 32,8% concordaram e 21% concordaram totalmente, enquanto 19,8% discordaram e 9,3% discordaram totalmente. Em relação a "Meu trabalho é solitário e isolado", 9,4% concordaram e 2,6% concordaram totalmente, enquanto 45,4% discordaram e 30,5% discordaram totalmente.

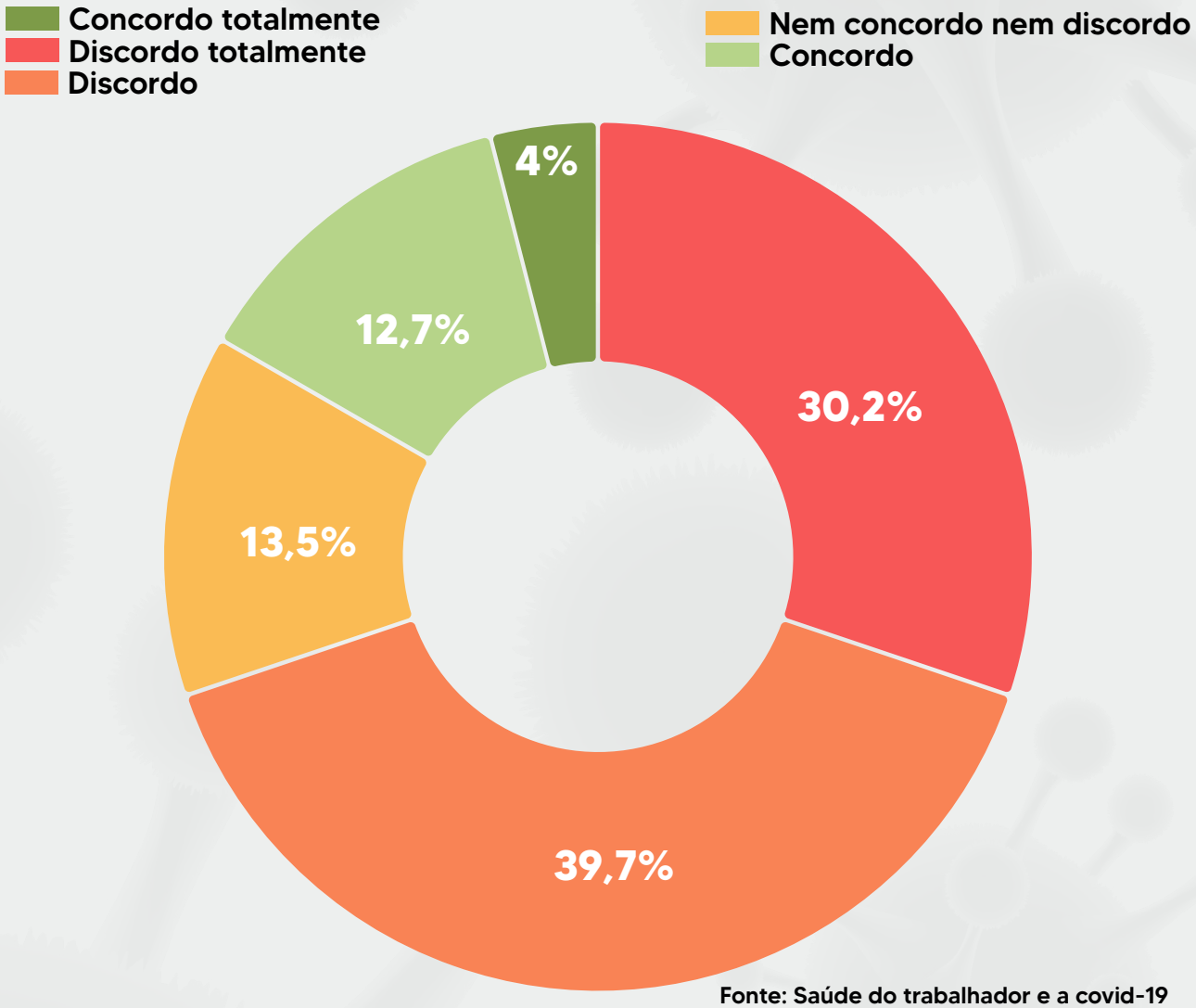
Gráfico 20. Meu trabalho é arriscado e perigoso



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Gráfico 21. Meu trabalho é solitário e isolado

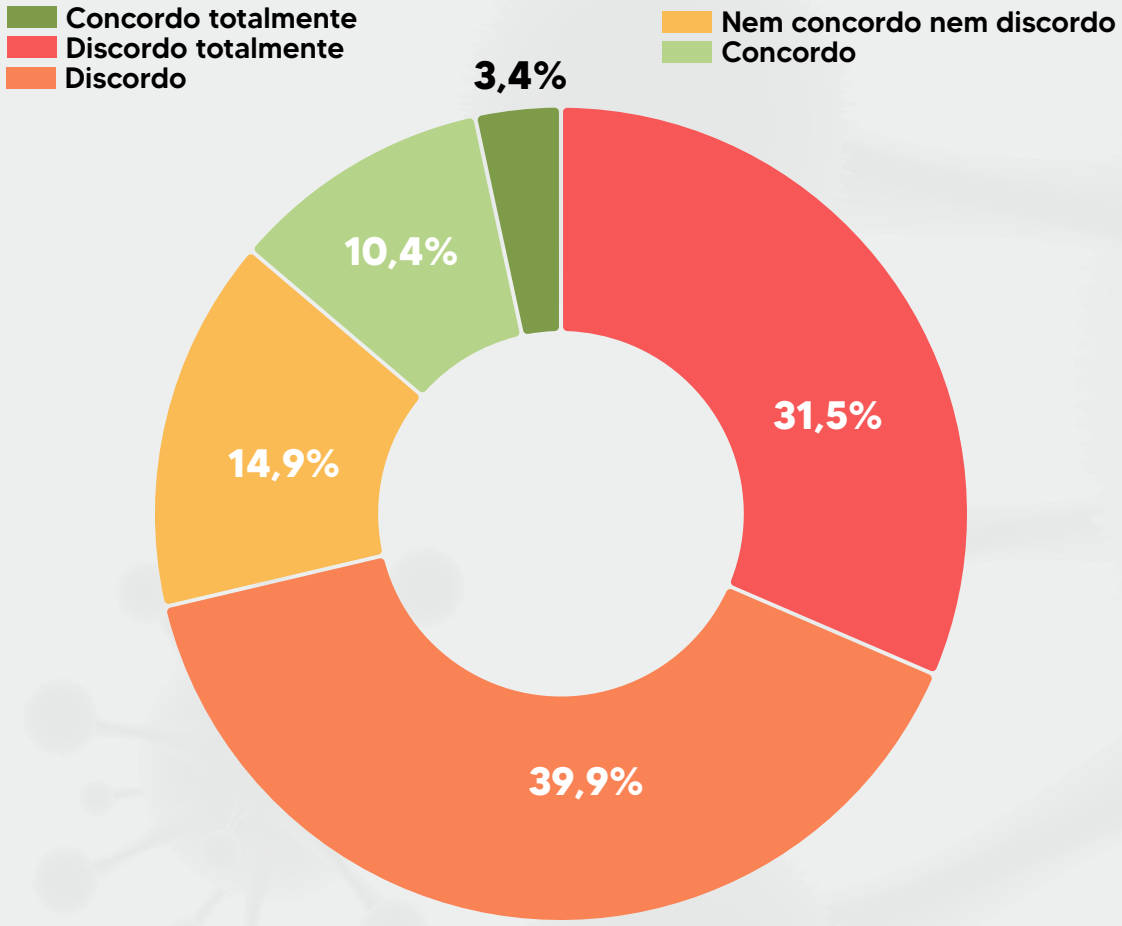


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Diante da afirmação “Meu trabalho é inseguro por falta de formação específica”, 10,4% concordaram e 3,4% concordaram totalmente, enquanto 39,9% discordaram e 31,5% discordaram totalmente. A partir de “Meu trabalho é inseguro por falta de experiência na área” 5,8% concordaram e 1,7% concordaram totalmente, enquanto 45,9% discordaram e 37,5% discordaram totalmente.

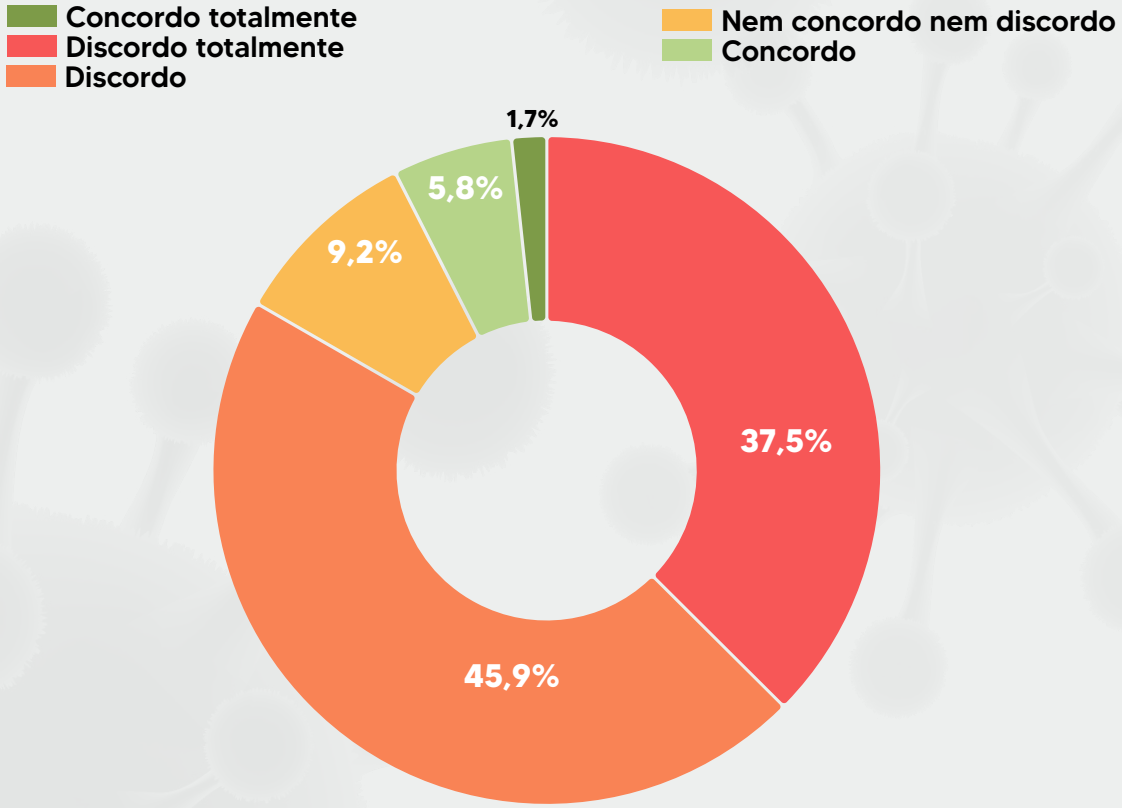


Gráfico 22. Meu trabalho é inseguro por falta de formação específica



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 23. Meu trabalho é inseguro por falta de experiência na área



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Recebimento de EPIs para o trabalho no combate à pandemia de covid-19

92,2% afirmaram receber EPIs para o seu trabalho durante o combate à pandemia de covid-19 e 7,8% alegaram não receber tais equipamentos. 12,3% receberam equipamentos em quantidades inferiores ao necessário; 8,8% receberam equipamentos de qualidade inferior ao que seria necessário; 11,4% receberam equipamentos em qualidade e quantidade inferiores ao necessário; 20,1% foram solicitados/as a economizar os equipamentos; 33,5% sempre receberam EPIs suficientes, em qualidade e quantidade, para realizar o meu trabalho; e 6,2% já precisaram comprar ou improvisar EPIs para levar para o trabalho.

Gráfico 24. Recebeu EPIs para o seu trabalho no combate à pandemia de covid-19

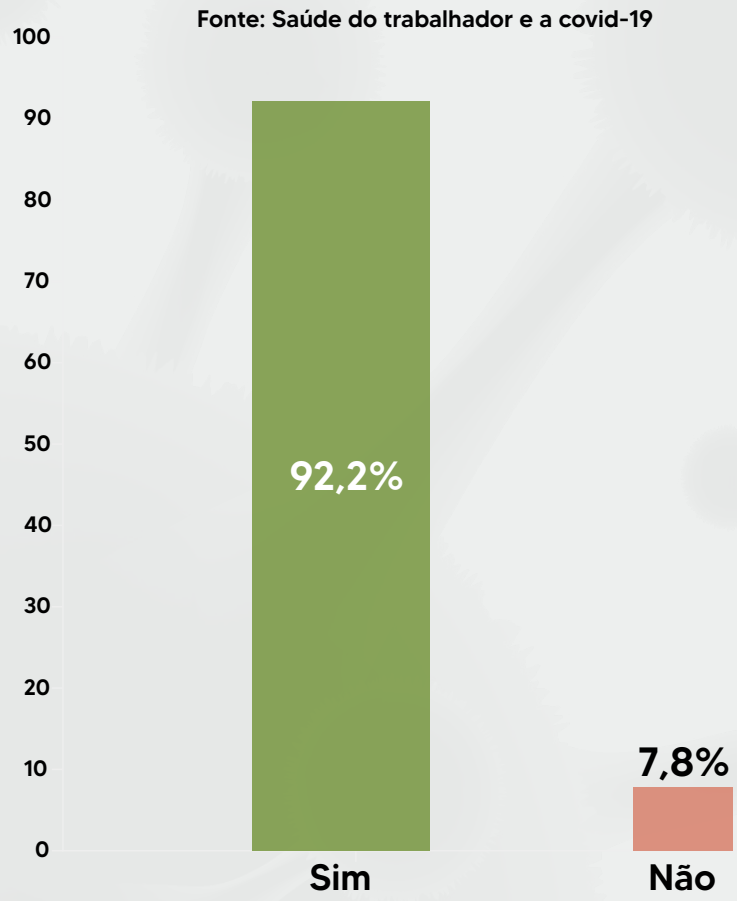
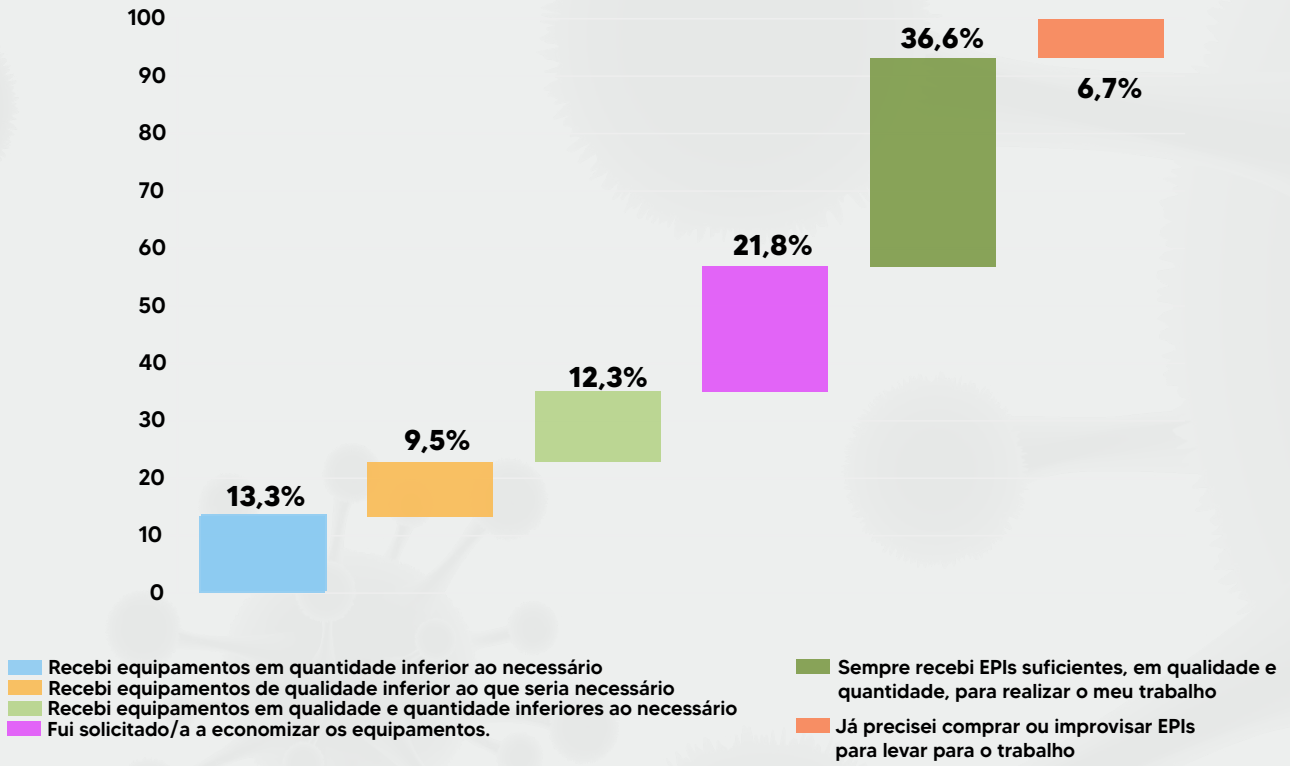




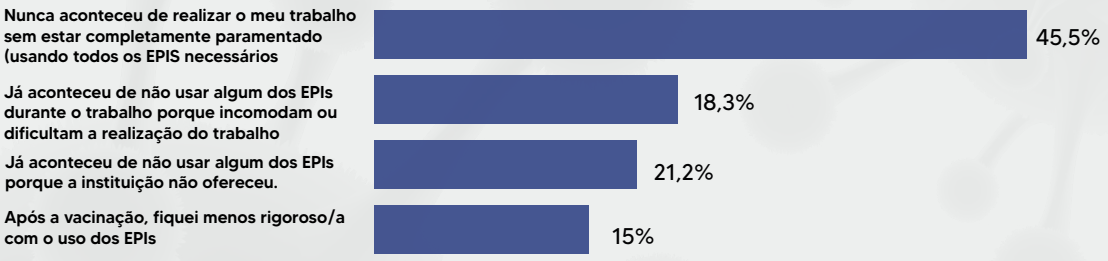
Gráfico 25. Realidade da oferta e condições dos EPIs



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Quando questionados/as sobre o uso dos EPIs no trabalho; 42,0% afirmaram que nunca aconteceu de realizarem seus respectivos trabalhos sem estarem completamente paramentados/as (usando todos os EPIs necessários); 16,8% declararam que já aconteceu de não usar algum dos EPIs durante o trabalho, porque incomodam ou dificultam a realização do trabalho; 19,5% que já aconteceu de não usarem EPIs porque a instituição não ofereceu; e 13,9% informaram que, após a vacinação, ficaram menos rigorosos/as com o uso dos EPIs.

Gráfico 26. O que mais representa o seu uso de EPIs no trabalho

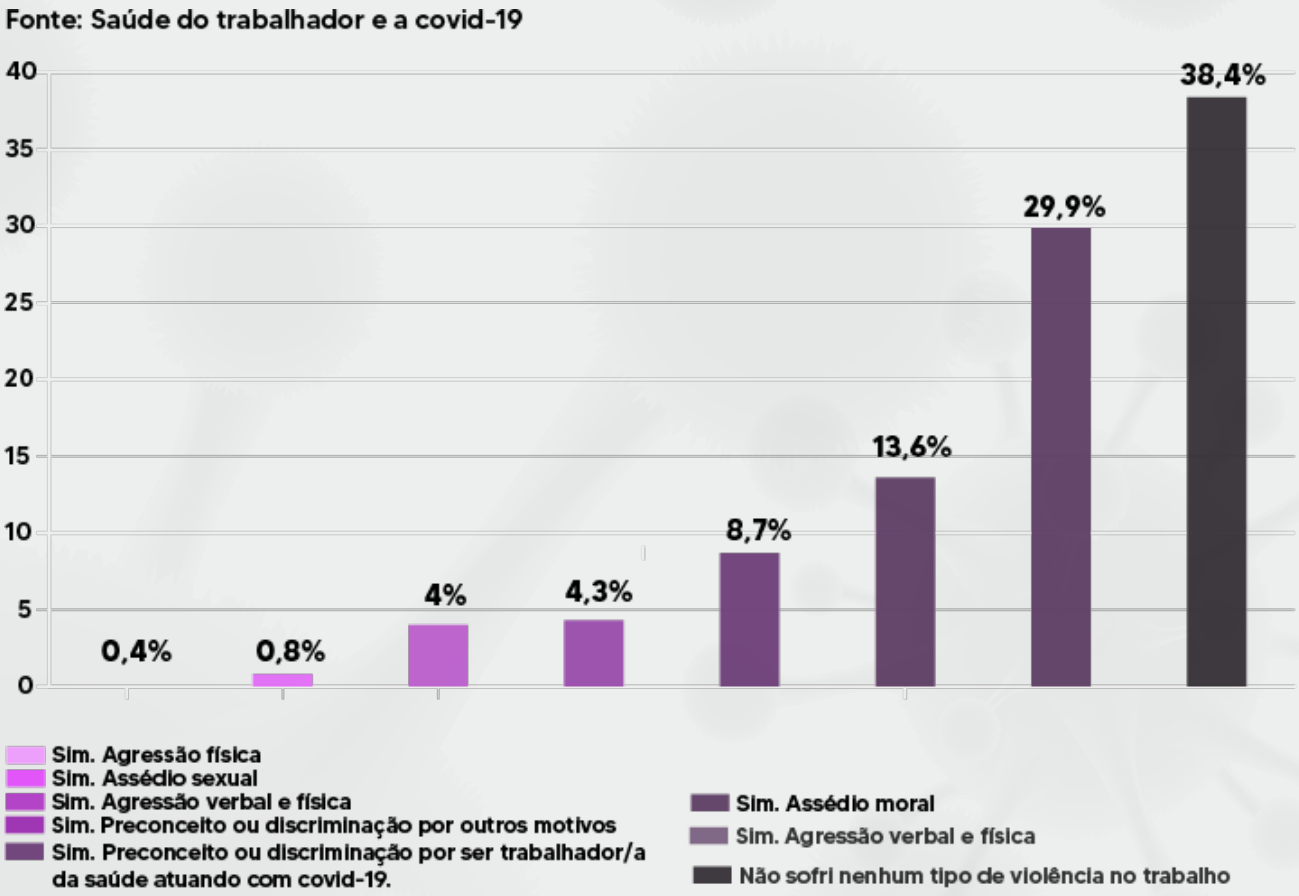


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Situações de violência vivenciadas no trabalho

Quando questionados/as sobre possíveis vivências de violências no trabalho, 29,9% relataram que já vivenciaram agressão verbal; 0,4% agressões físicas; 4,0% agressão física e verbal; 0,8% expuseram que já vivenciaram assédio sexual; 13,6% assédio moral; 8,7% preconceito ou discriminação por ser trabalhador/a da saúde atuando com covid-19; 4,3% preconceito ou discriminação por outros motivos; e 38,4% afirmaram que não sofreram nenhum tipo de violência no trabalho.

Gráfico 27. Já vivenciou algum tipo de violência no trabalho?



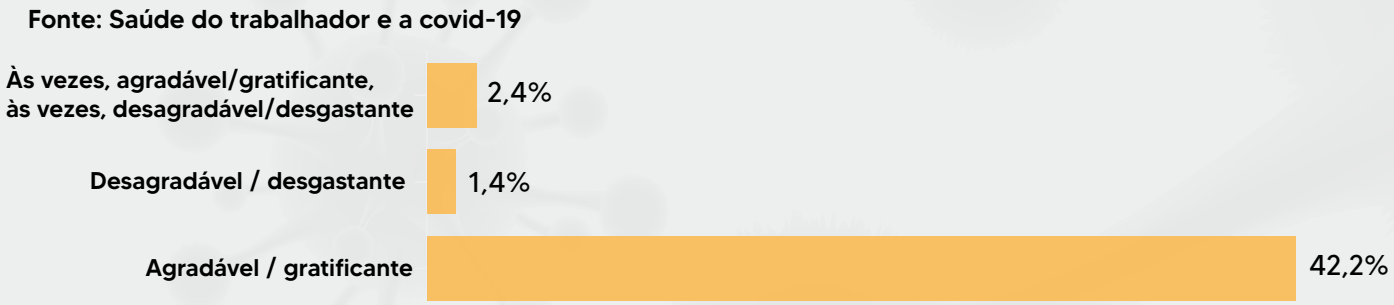


Relações com o público (clientes/ usuários/as)

Contato com o público

Em relação ao contato com o público, 1,4% descreveram como desagradável / desgastante e 42,2% apontaram que, às vezes, é agradável / gratificante e, às vezes, é desagradável / desgastante (56,4%).

Gráfico 28. Como caracteriza o contato com o público?



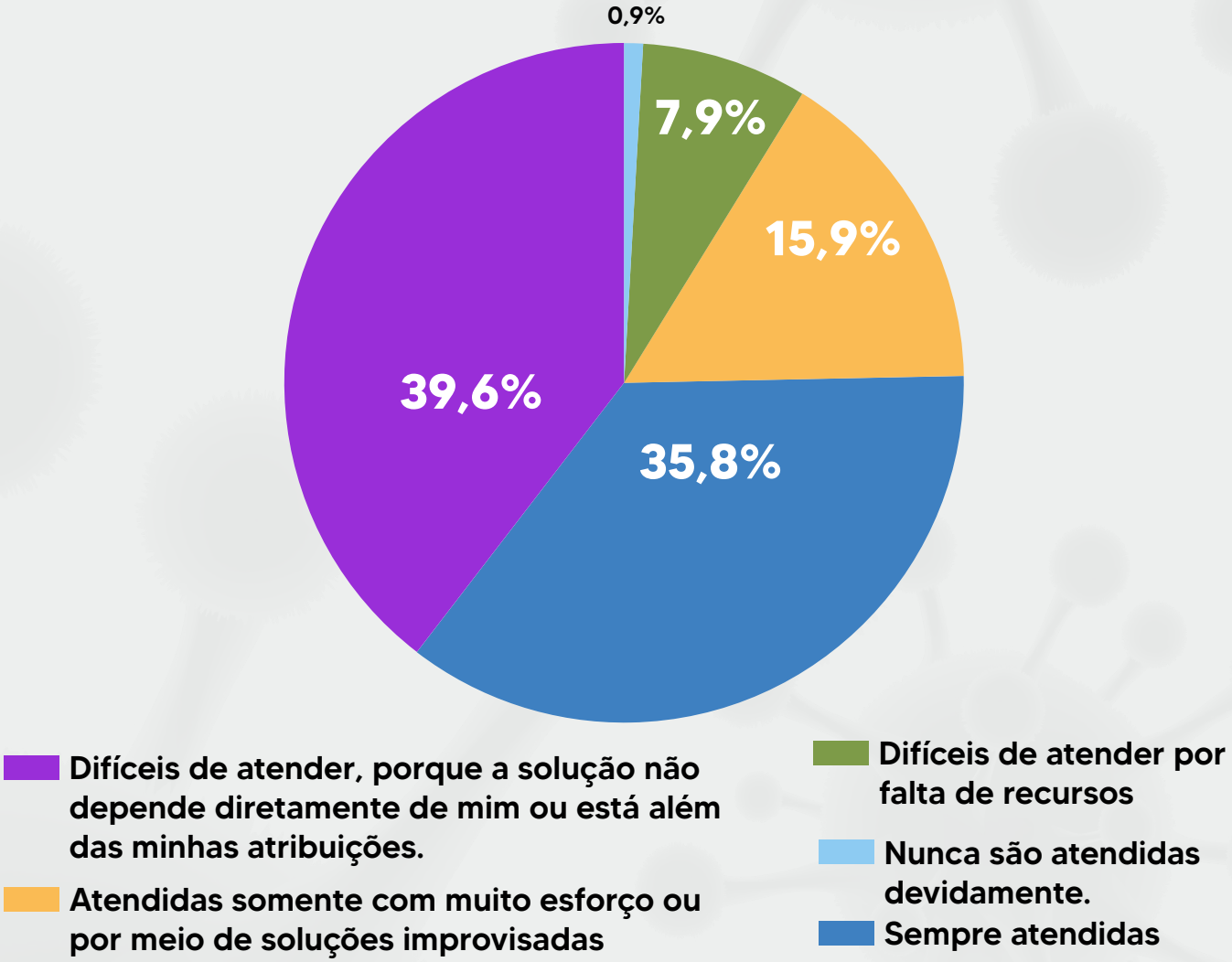
Exigências e/ou necessidades de pacientes ou usuários/as



No que se refere às exigências e/ou necessidades dos pacientes / usuários/as, 35,8% afirmam serem sempre atendidas; 15,9% mencionaram que são atendidas somente com muito esforço ou por meio de soluções improvisadas; 7,9% apontam que são difíceis de atender por falta de recursos; 39,6% que são difíceis de atender, porque a solução não depende diretamente de deles/as ou está além de suas atribuições; e 9% alegam que nunca são atendidas devidamente.

Gráfico 29. As exigências e/ou necessidades dos pacientes/ usuários/as são:

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

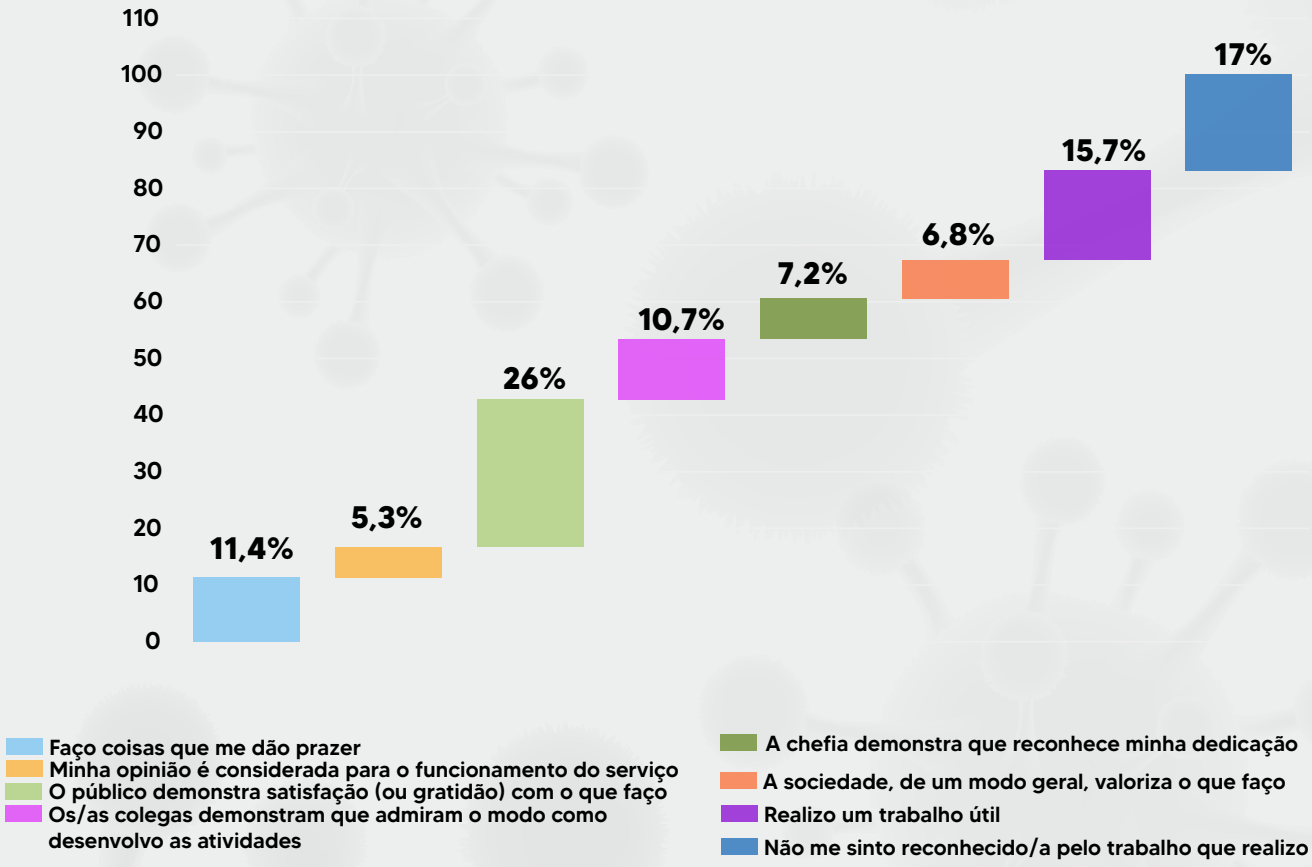




Reconhecimento e satisfação no trabalho

Em relação ao reconhecimento e à satisfação no trabalho, 26% dos/das participantes relataram que o público demonstra satisfação (ou gratidão) com o que fazem; seguidos por 17% que afirmaram não se sentirem reconhecidos/as pelo trabalho realizado; 15,7% que entendem realizar um trabalho útil; 10,7% que colegas demonstram que admiram o modo como desenvolvem as atividades; 7,2% que a chefia demonstra que reconhece a sua dedicação; 6,8% que a sociedade valoriza o que fazem; e 5,3% que a sua opinião é considerada para o funcionamento do serviço.

Gráfico 30. O que mais representa a percepção sobre o reconhecimento e satisfação no trabalho



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Diante da afirmação “Meu trabalho possui reconhecimento social”, 36,3% concordaram e 14% concordaram totalmente, enquanto 20,8% discordaram e 10,1% discordaram totalmente. Sobre a colocação “Meu trabalho possui reconhecimento da minha família”, 39,6% concordaram e 42% concordaram totalmente, enquanto 5,5% discordaram e 2,6% discordaram totalmente.

A respeito de “Sinto que meu trabalho me faz sofrer preconceito e discriminação”, 12,7% concordaram e 4% concordaram totalmente, enquanto 39,7% discordaram e 30,2% discordaram totalmente.

Gráfico 31. Meu trabalho possui reconhecimento social

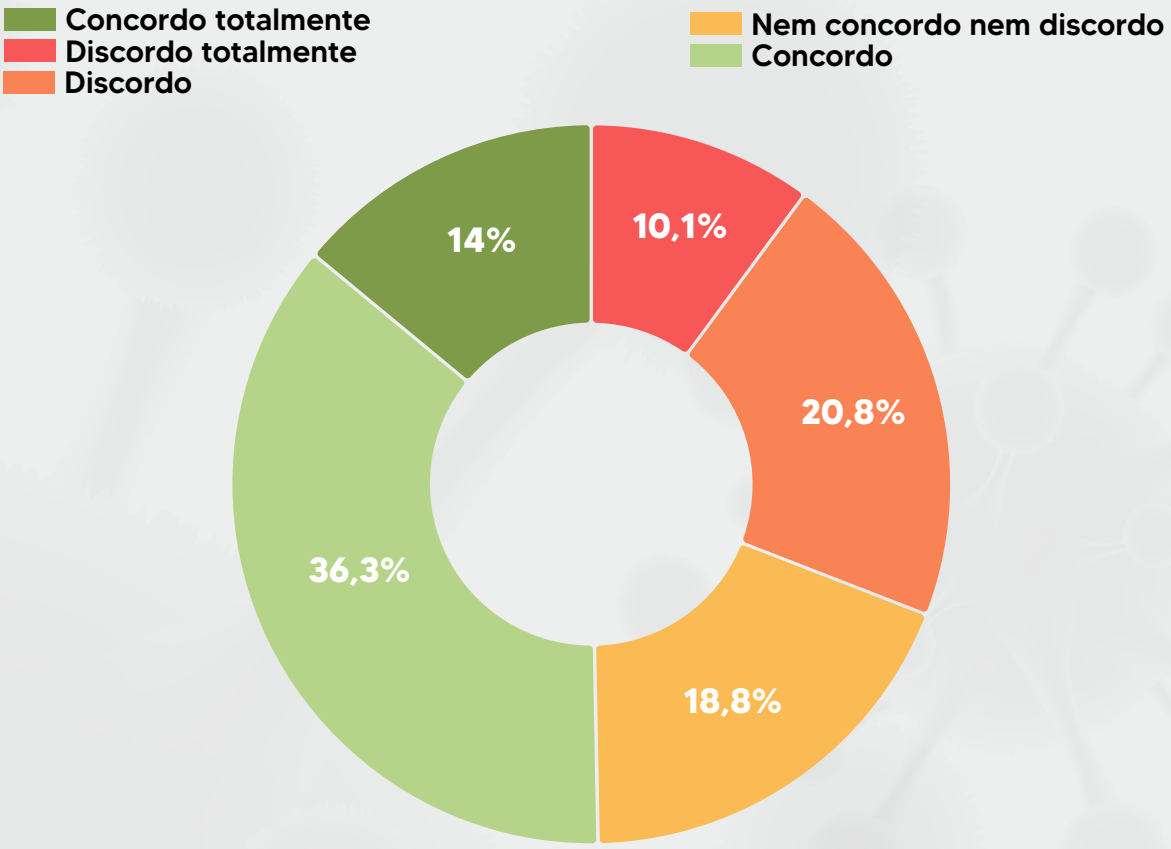
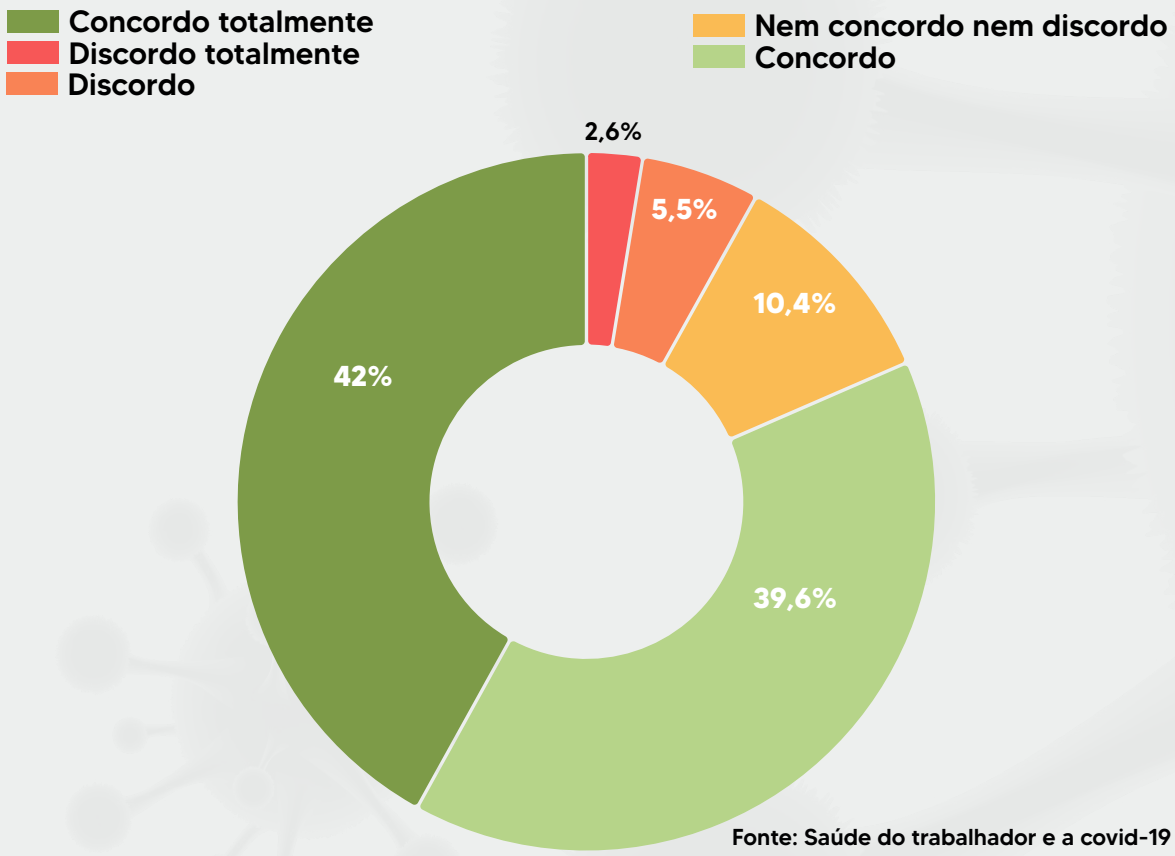
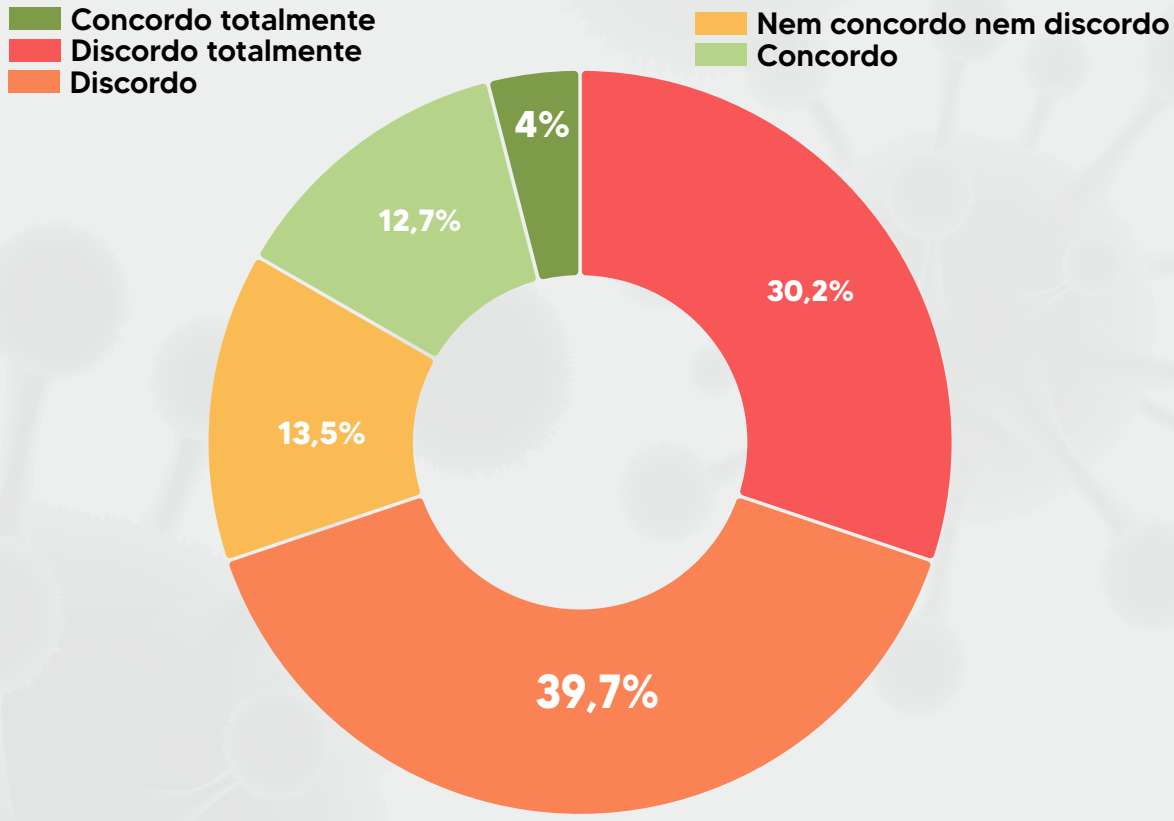


Gráfico 32. Meu trabalho possui reconhecimento da minha família



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 33. Sinto que meu trabalho me faz sofrer preconceito e discriminação

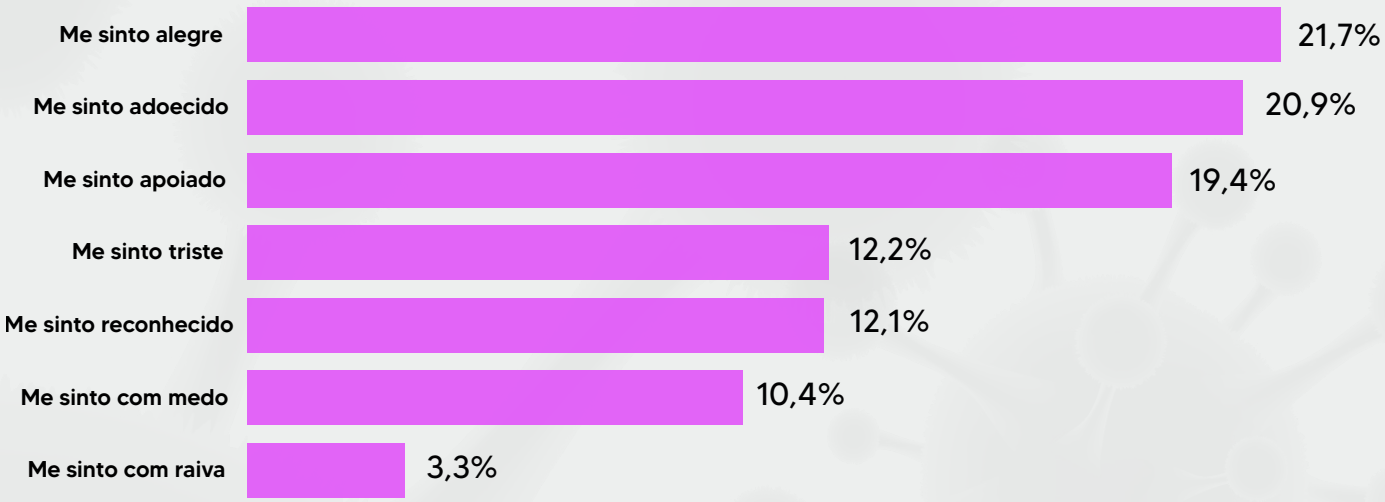


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Sentimentos e satisfação no dia a dia de trabalho

O gráfico 34 retrata sobre os sentimentos mais presentes no dia a dia de trabalho de profissionais da saúde. Em sua maioria, os/as trabalhadores/as relataram se sentir alegres (21,7%), adoecidos/as (20,9%), apoiados/as (19,4%) e tristes (12,2%) no ambiente de trabalho. Outros sentimentos também podem ser observados em menor incidência no cotidiano de trabalho, uma vez que os/as demais trabalhadores/as alegaram sentir-se reconhecidos/as (12,1%), com medo (10,4%) e com raiva (3,3%) no espaço em que desenvolvem suas atividades laborais.

Gráfico 34. Sentimento mais latente no dia-a-dia de trabalho

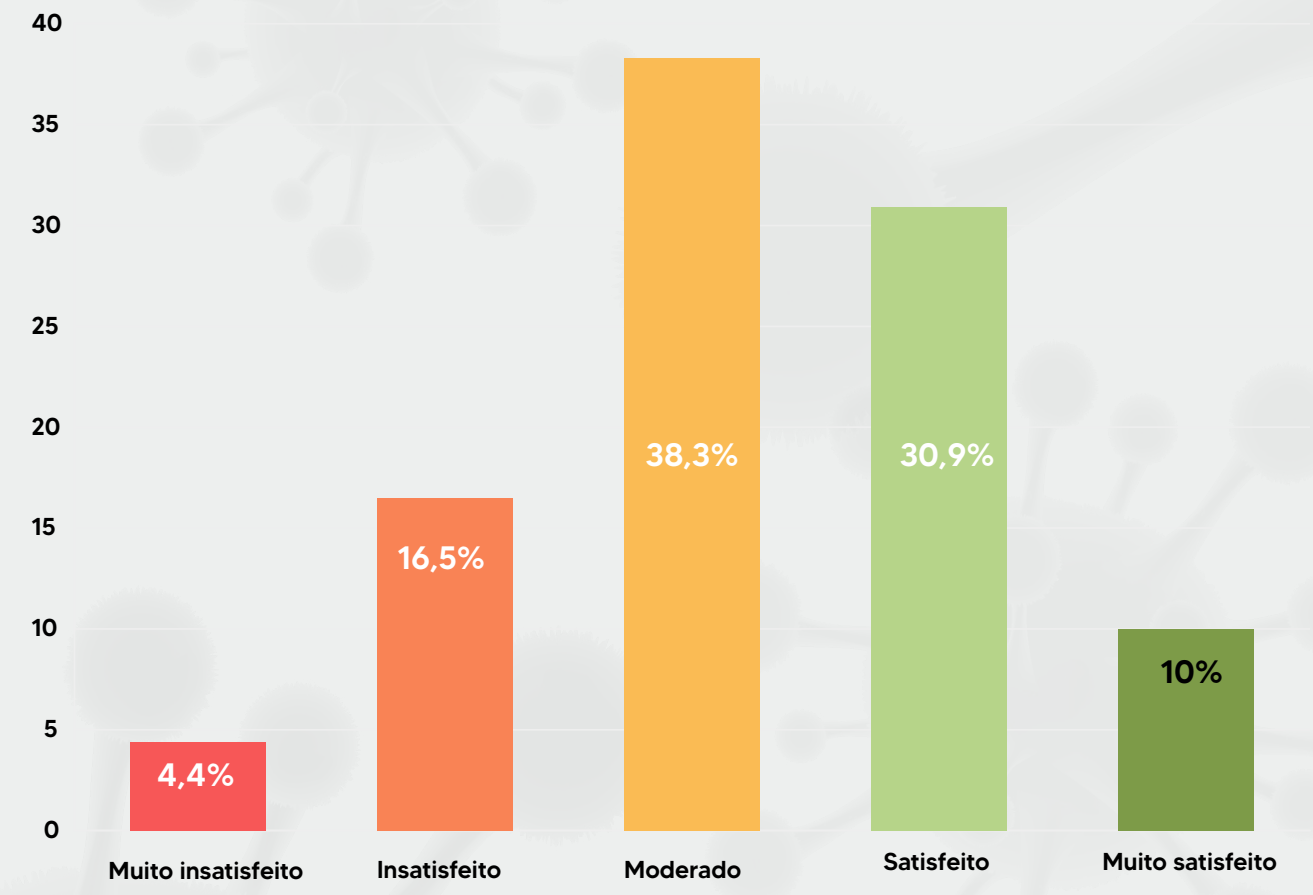


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



No que tange a satisfação no trabalho durante a pandemia, 38,3% dos/das participantes demonstraram se sentir moderadamente satisfeitos/as; seguidos por 30,9% que se sentiram satisfeitos/as; 10,0% que se sentem muito satisfeitos/as; 16,5% insatisfeitos/as; e 4,4% muito insatisfeitos/as.

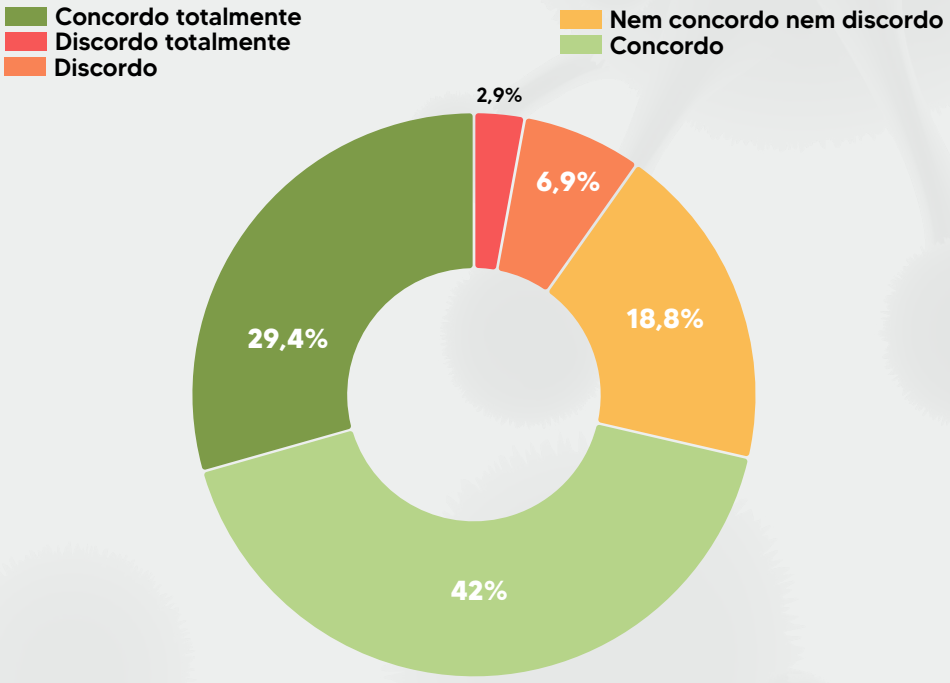
Gráfico 35. Como você se sente, de forma geral, em relação ao seu trabalho durante a pandemia?



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Quando pedidos que avaliassem o quanto concordavam com determinadas afirmações sobre o seu trabalho, em questões como “Meu trabalho me identifica / diz quem eu sou”, 42% concordaram e 29,4% concordaram totalmente, enquanto, do restante, apenas 6,9% discordaram e 2,9% discordaram totalmente.

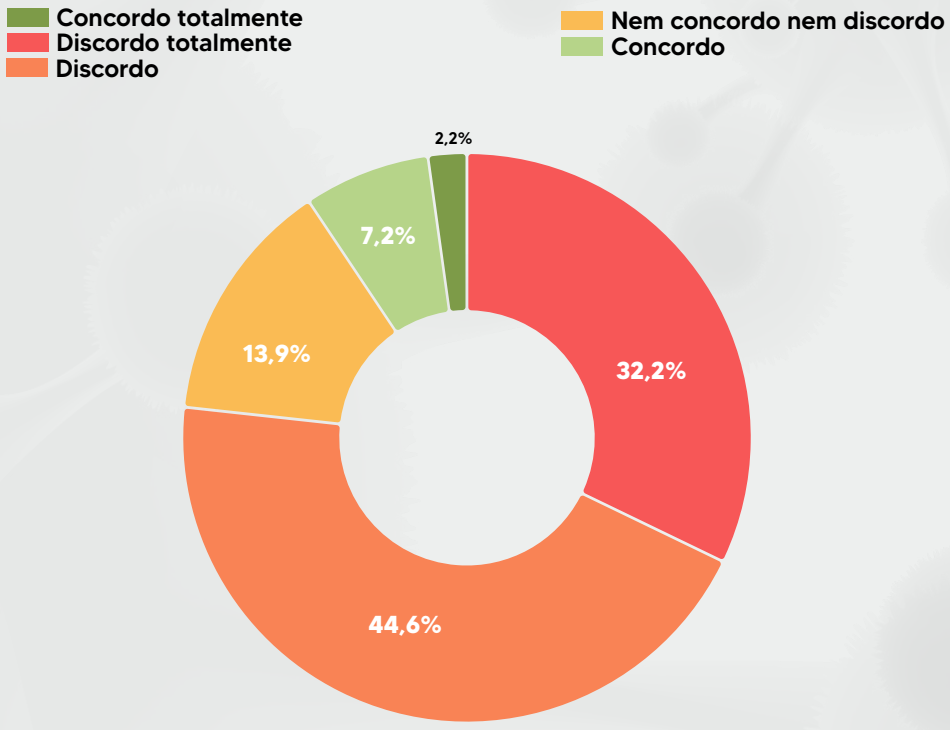
Gráfico 36. Meu trabalho me identifica/ diz quem eu sou



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

A partir da afirmação "Meu trabalho me paralisa e me deixa impotente", 7,2% concordaram e 2,2% concordaram totalmente, enquanto 44,6% discordaram e 32,2% discordaram totalmente.

Gráfico 37. Meu trabalho me paralisa e me deixa impotente

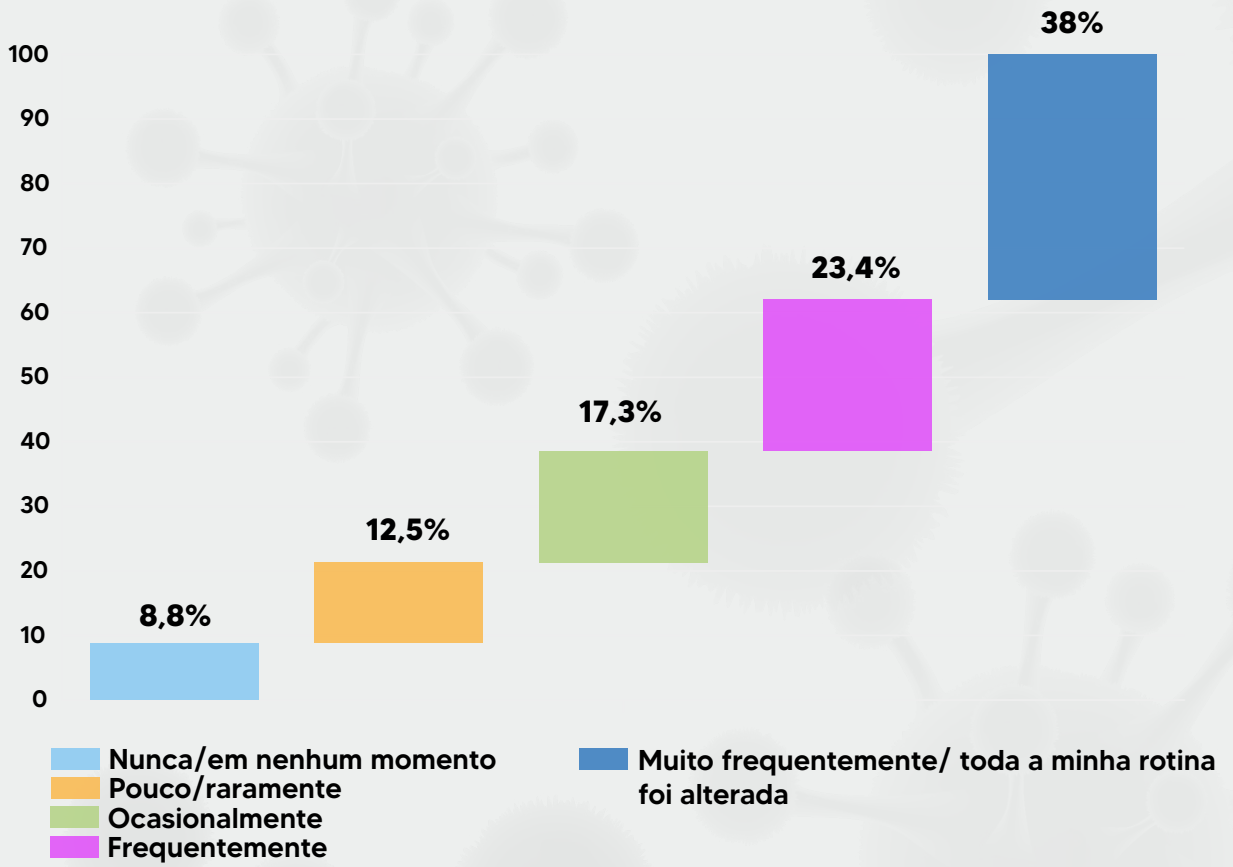


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Relação com amigos e familiares afetada pelo trabalho com a covid-19 durante a pandemia

Em relação aos impactos do trabalho com a covid-19 nas relações interpessoais com amigos e familiares, 38% relataram que os impactos eram muito frequentes, chegando a alterar toda a rotina de trabalho; 23,4% afirmaram ser frequente; 17,3%, ocasional; 12,5%, pouco ou raro; e 8,8% não sentiram as suas relações com amigos e familiares afetadas em nenhum momento.

Gráfico 38. Durante a pandemia, com que frequência a sua relação com amigos e familiares foi afetada pelo seu trabalho com a covid-19?



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Saúde e trabalho

Ações em saúde mental ofertadas pelas instituições aos/às trabalhadores/as durante a pandemia

60,8% responderam que não foram oferecidas ações em saúde mental para trabalhadores/as durante a pandemia pela instituição na qual trabalhavam.

Nesse sentido, dentre quem afirmou ter tido acesso a ações em saúde mental, avaliaram como importantes para lidar com as dificuldades do trabalho por 38,4% dos/das respondentes, enquanto, para 13,2%, elas foram pontuais e não ajudaram a realizar o trabalho durante a pandemia. Os 48,3% restantes afirmaram que tais ações deveriam ter sido feitas de forma mais sistemática.

Gráfico 39. A instituição onde você trabalha ofereceu ações de saúde mental para seus trabalhadores durante a pandemia?

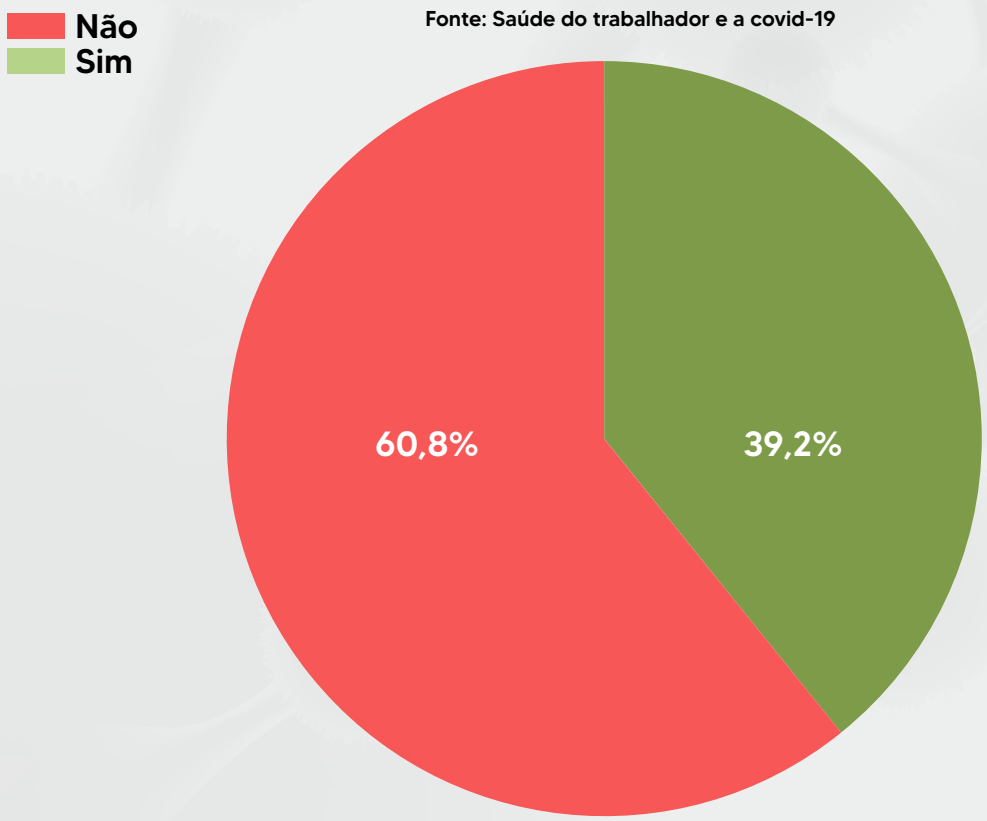
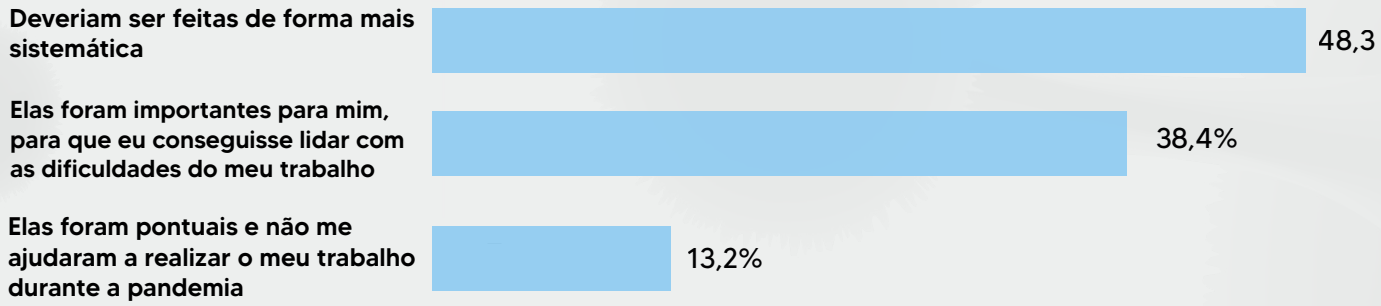


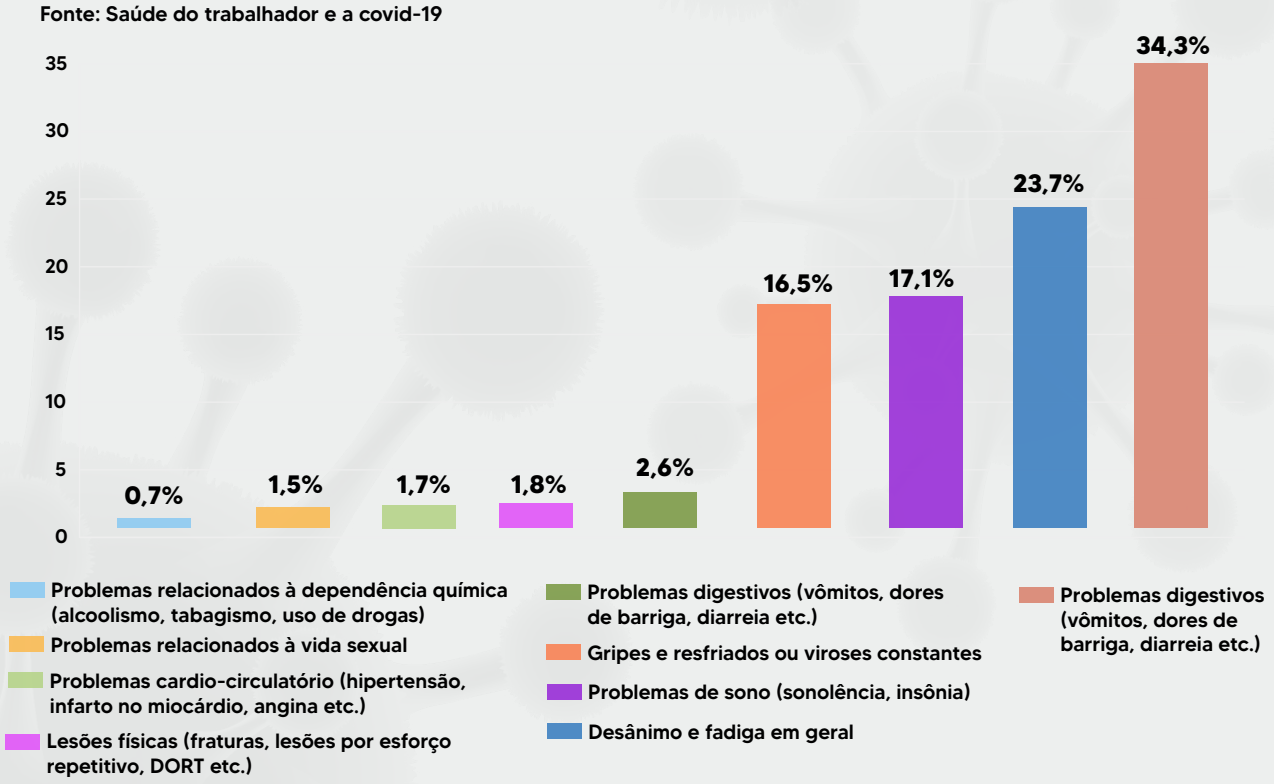
Gráfico 40. Como você avalia as ações oferecidas em saúde mental para sua saúde, enquanto trabalhador/a?



Causa ou agravamento de sintomas a partir do trabalho na pandemia

Em relação ao surgimento ou agravo de sintomas provocados pelo trabalho na pandemia, 98,1% afirmaram ter percebido o aparecimento ou agravo de algum problema de saúde. Dentre esses, 34,3% dos/das participantes se identificaram com o adoecimento mental ou estresse; seguidos por 23,7%, que informaram ter desânimo e fadiga em geral em decorrência do trabalho. 17,1% informaram ter problemas no sono; e 16,5% que apresentaram gripes e resfriados ou viroses constantes. Os sintomas com menor incidência de respostas foram problemas cardiocirculatórios (1,7%), problemas relacionados à vida sexual (1,5%) e dependência química (0,7%).

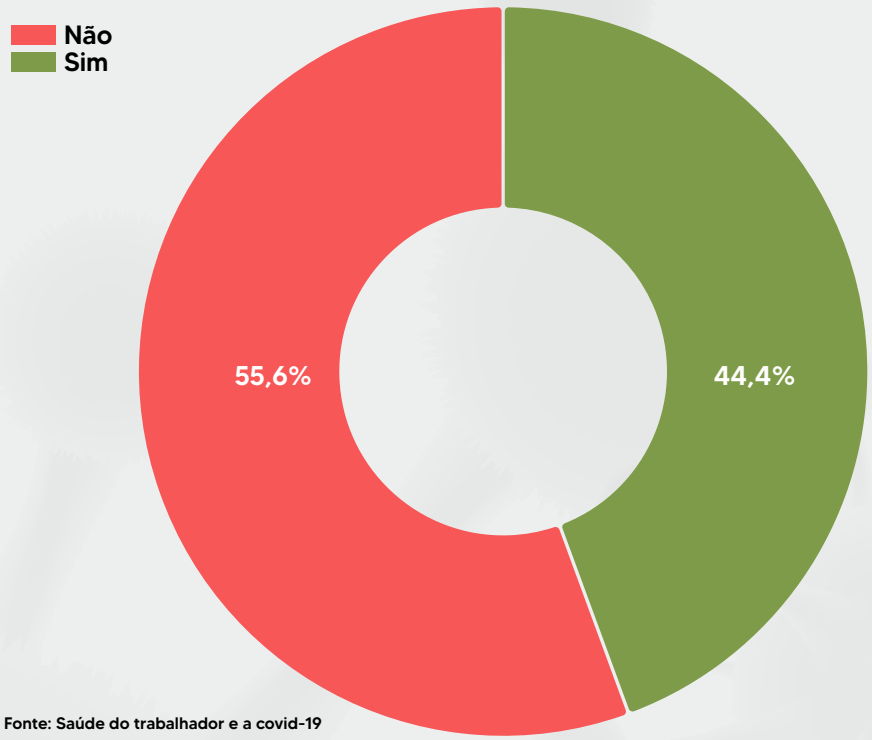
Gráfico 41. O seu trabalho na pandemia causou ou agravou algum desses sintomas abaixo?



Uso de medicamentos durante a pandemia

O começo ou intensificação do uso de medicamentos durante a pandemia foi apontado por 44,4% dos/das participantes. Dentre os medicamentos referidos se destacam os psicotrópicos (40,7%); analgésicos (27,6%); vitaminas (23,6%); e anti-inflamatórios (8,1%).

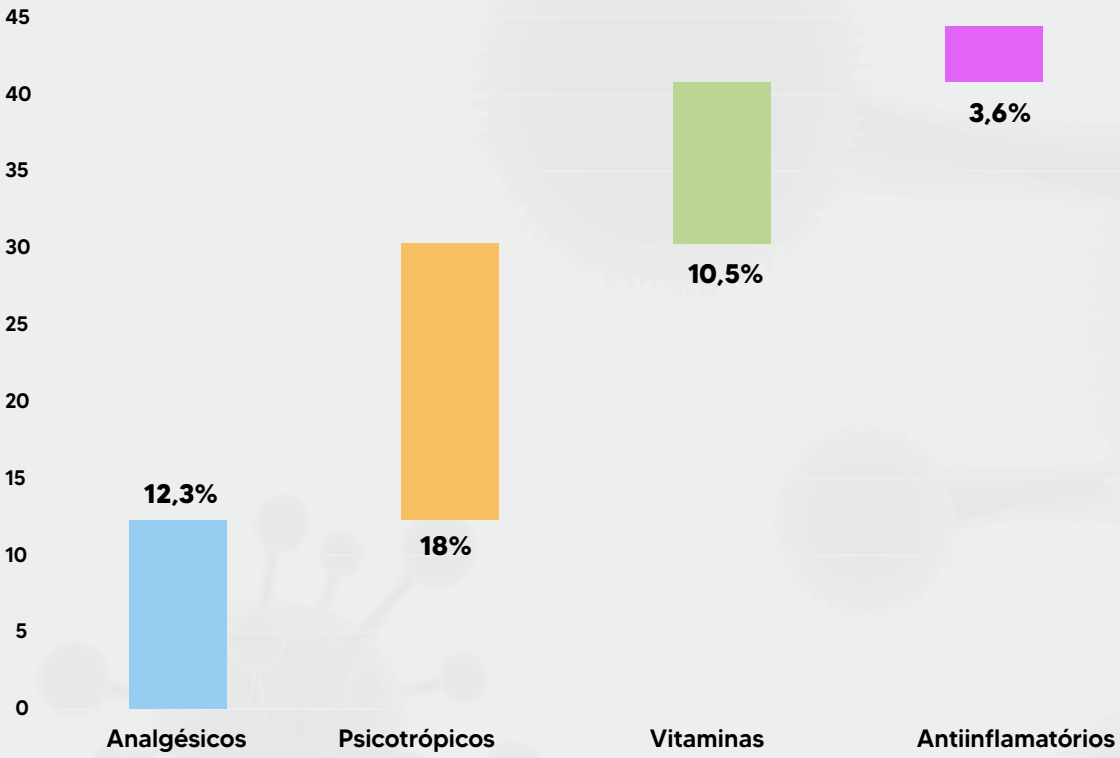
Gráfico 42. Você começou ou intensificou o uso de algum medicamento durante a pandemia?



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Gráfico 43. Esses medicamentos, em sua maioria, foram:



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Aplicabilidade para o SUS

Esperamos que nosso estudo possa contribuir no sentido de dar visibilidade às condições de trabalho e aos riscos aos quais os/as profissionais de saúde estão submetidos/as, que se intensificaram no cenário da pandemia, mas, na realidade, já estão presentes no trabalho no SUS anteriormente.

Nosso estudo demonstra alguns índices preocupantes, principalmente no que se refere às questões de saúde mental para os/as profissionais da saúde. Nesse sentido, esperamos que os resultados suscitem a construção de políticas de saúde do/a trabalhador/a, sobretudo os/as que foram foco de todo o nosso período de pesquisas, entre 2020 e 2022.

Ressaltamos a necessidade de que haja maior atenção e cuidado ao/à trabalhador/a da saúde, com políticas públicas permanentes voltadas especificamente para a prevenção e a promoção da saúde mental e da qualidade de vida no trabalho desses/as trabalhadores/as.

Destacamos ainda a necessidade de programas de formação continuada para gestores, profissionais das áreas de saúde e segurança no trabalho e gestão de pessoas dos serviços de saúde do SUS para que possam desenvolver ações de promoção e prevenção à saúde dos/das trabalhadores nas diversas instituições de saúde do SUS, em todos os níveis de atenção.

Outro aspecto que gostaríamos de evidenciar é com relação às estratégias de acompanhamento e diagnóstico de como está a saúde desses/as trabalhadores/as. Nesse sentido, propomos a utilização do nosso aplicativo Trabs, disponível para os sistemas Android, e do nosso observatório, para acompanhamento das condições de saúde e segurança do trabalho.



REDES SOCIAIS E CONTATOS

Instagram: @saudedotrabalhador_covid19

Facebook: fb.com/saudedotrabalhadorcovid19

E-mail: saudedotrabalhador_covid19@cchla.ufpb.br

Twitter: @saudetrab_covid

Endereço: Departamento de Psicologia – Universidade Federal da Paraíba – CCHLA – Bloco Humanístico, Campus I – Castelo Branco I, João Pessoa – PB, CEP. 58051-900



